ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

(Özel Hastane/Dal Hastaneleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM 1
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç..... 1
2.Kapsam..... 1
3.Dayanak..... 1
4.Tanımlar.....2
4.1.Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2.Acil Sağlık Aracı 2
4.3.Ambulans.....2
4.4.Ambulans Servisi 3
4.5.Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi 3
4.6.Dal Hastaneleri 3
4.7.Doku Tipleme Laboratuarı 3
4.8.Evde Bakım Birimi 3
4.9.Evde Bakım Hizmeti 3
4.10. Evde Bakım Merkezi 4
4.11.Faaliyet İzin Belgesi 4
4.12.Hasta Yatak Sayısı 4
4.13.Hastane Yatak Sayısı 4
4.14.Kadrolu Uzman Tabip/Kadrolu Tabip 4
4.15.Kordon Kanı Bankası 5
4.16.Madde Bağımlılığı Tedavi Özel Merkezi 5
4.17.Nöbetçi Tabip 5
4.18.Organ Kaynağı Merkezi 5
4.19.Organ ve Doku Nakli 5
4.20.Özel Hastane 5
4.21.Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi 6
4.22.Ruhsatname 6
4.23.Tam Zamanlı Çalışma 6

4.24.Uygunluk Belgesi 6
4.25.Uzmanlık Dalı 6
4.26.Üremeye Yardımcı Tedavi Özel Merkezi 7

II.BÖLÜM
ÖZEL HASTANE İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 9
2.Özel Hastane İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri..... 16
2.1. Kanunlar 16
2.2. Tüzükler 17
2.3. Yönetmelikler 18
2.4. Genelgeler 19
2.5. Yönergeler 20
3.Özel Hastaneler Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar 21
3.1.Özel Hastanelerin Açılması, Devri ve Kapatılması.....21
3.1.1.Hastanenin Bir Bölümünde Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması.....23
3.1.2.Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması.....25
3.1.3.Hastanenin Kapatılması (Ruhsatın Geri Alınması) 26
3.1.4.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin Açılması, Devri, Kapatılması.....26
3.1.5.Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması.....28
3.1.6.Kordon Kanı Bankalarının Açılması, Devri, Kapatılması.....29
3.1.7.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması 30
3.1.8.Ambulans Servislerinin Açılması, Devri, Kapatılması ...31
3.1.9.Evde Bakım Merkez/Birimlerinin Açılması, Kapatılması 32
3.2. Özel Hastanelerde Görevlendirilecek Personeller 33

3.3. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları 40
3.4. Özel Hastane Çalışanlarının Çalışma Saatleri 42
3.5. Özel Hastanenin Çalışma Saatleri, Dönemleri 43
3.6. Özel Hastanenin İl Sağlık Müdürlüğü Personeli ve Bakanlık Müfettişlerince Denetlenmesi 44
3.6.1.Özel Hastanelerin Denetimi.....44
3.6.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin Denetimi...55
3.6.3.Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin Denetimi.....57
3.6.4.Kordon Kanı Bankalarının Denetimi.....57
3.6.5.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Denetimi .58
3.6.6.Ambulans Servislerinin Denetimi.....58
3.6.7.Evde Bakım Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşlarının Denetimi.....60

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 64
2.İncelemenin Aşamaları 65
2.1.Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 65
2.2.İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 66
2.3.İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 67
2.4.Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar 68

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

1.İl Sağlık Müdürlüklerine Verilmesi Gereken Belgeler 71
1.1.Ön İzin Belgesi, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler 71

1.2.Özel Hastanelerin Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 76
1.3.Mesul Müdür Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 77
1.4.Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 78
1.5.Uzmanlık Dalı, Tıbbi Hizmet Birimi İlavesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler 78
1.6.Özel Hastanelerde Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler.....79
2.İl Sağlık Müdürlüklerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....79
2.1.İncelenecek Kayıt ve Belgeler 79
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 80

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Özel Hastanelerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler.....83
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler.....83
1.2.Tutulmazı Zorunlu Belgeler.....86
2.İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 88
2.1.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 88
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....88
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi.....89
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi.....90

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Özel Hastane/Dal Hastanesi İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri.....93
2.Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri 94
2.1.Çalışanların Sigortalılık Durumu.....94
2.1.1.Tam/Kısmi Zamanlı Bağımlı Çalışanlar.....94
2.1.2.Şirket Ortaklarının Çalışması.....95
2.1.3.Serbest Çalışan Hekimden Hizmet Satın Alma.....95
2.1.4.2368 Sayılı Kanuna Tabii Olanların Serbest Çalışmaları...96
2.2.Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi.....97
3.Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 97
4.Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 99
4.1.Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler 99
4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 102
4.2.1.Özel Hastaneler 102
4.2.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri 111
4.2.3.Organ ve Doku Nakli Merkezleri 113
4.2.4. Böbrek Nakli Merkezleri.....113
4.2.5.Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri.....115
4.2.6.Karaciğer Nakli Merkezleri 117
4.2.7.Kemik İliği Nakli ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Servisleri.....118
4.2.8. Doku Tipleme Laboratuarı.....118
4.2.9.Kordon Kanı Bankaları.....121
4.2.10.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri.....121
4.2.11.Ambulans Servisleri 124
4.2.12.Evde Bakım Merkez ve Birimleri 125
4.2.13. Sağlık Personeli Dışındaki İdari Personelle İlgili Değerlendirme.....126

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 127
2.Rapor Düzenlenmesi İle İlgili Genel Hususlar.....127

EKLER.....131

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan özel hastane/özel dal hastanesi işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

2. Kapsam[1]

Bu rehber, Sağlık Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın çalışan özel hastane/özel dal hastanesi (madde bağımlılığı tedavi merkezleri, organ ve doku nakli merkezleri, kordon kanı bankaları, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, evde bakım birimleri ve ambulans servisleri dahil) işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından

---

[1] Bahse konu merkez/banka/birim ve ambulans servisleri, (üremeye yardımcı tedavi merkezleri, evde bakım birimleri ve ambulans servisleri) Sağlık Bakanlığı tarafından müstakil olarak ruhsatlandırılabilecekleri gibi özel hastane bünyesinde bir ünite şeklinde faaliyette bulunup ruhsatlandırılabildikleri için rehberin kapsamı içersine alınmışlardır.

yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Acil Sağlık Aracı

Can kurtarma amacıyla ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere hazırlanmış araçları,

4.3. Ambulans

Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve bu Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,

4.4. Ambulans Servisi

Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,

4.5. Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi

Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

4.6. Dal Hastaneleri

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, kurulan en az on hasta yatağı bulunan özel hastaneleri,

4.7. Doku Tipleme Laboratuarı

Donör adayı ile alıcıların doku tiplemelerini yapabilecek donanım ve personele sahip laboratuarları,

4.8. Evde Bakım Birimi

Evde bakım hizmeti vermek üzere hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi, poliklinik gibi özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan evde bakım birimini,

4.9. Evde Bakım Hizmeti

Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin

sunulmasını,

4.10. Evde Bakım Merkezi

Özel hukuk tüzel kişilerine veya gerçek kişilere ait olup, sadece evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet gösteren müstakil evde bakım merkezini,

4.11. Faaliyet İzin Belgesi

Özel hastaneler yönetmeliğinde örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

4.12. Hasta Yatak Sayısı

Bir özel hastanede yoğun bakım yatağı ve gözlem yatağı haricinde hastaların yatacağı yatak sayısının toplamını,

4.13. Hastane Yatak Sayısı

Bir özel hastanedeki hasta yatak sayıları, yoğun bakım yatak sayıları ve gözlem yatak sayılarının toplamından oluşan yatak sayısını,

4.14. Kadrolu Uzman Tabip/Kadrolu Tabip

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabibi,

4.15. Kordon Kanı Bankası

Kordon kanı toplama, işleme, saklama amacıyla kurulan sağlık kuruluşunu,

4.16. Madde Bağımlılığı Tedavi Özel Merkezi

Madde bağımlılarına yönelik her türlü tedavi usûllerinin uygulandığı, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan özel hastaneler bünyesindeki madde bağımlılığı tedavi merkezlerini veya sadece bu maksatla açılmış olan müstakil madde bağımlılığı tedavi merkezlerini,

4.17. Nöbetçi Tabip

Bir sağlık kuruluşunun hizmet verdiği genel çalışma saatleri dışındaki zamanda, gözlem altındaki hastaların ve/veya acil vakaların tıbbi işlemlerinden sorumlu olarak nöbet hizmetini yürüten tabibi,

4.18. Organ Kaynağı Merkezi

Beyin ölümü kriterlerini tespit edebilecek donanım ve personele sahip merkezleri,

4.19. Organ ve Doku Nakli

Terminal dönemdeki hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanan organ ve doku nakli ameliyesini,

4.20. Özel Hastane

Özel hastaneler yönetmeliği kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak

muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az yirmi beş[2] yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını,

4.21. Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi

Organ ve doku nakillerinin uygulandığı, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait tedavi merkezlerini,

4.22. Ruhsatname

Özel hastanelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve açılışta hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldığı belgeyi,

4.23. Tam Zamanlı Çalışma

Sağlık çalışanlarının tüm mesailerini çalıştıkları sağlık kuruluşuna hasretmelerini,

4.24. Uygunluk Belgesi

Özel sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

4.25. Uzmanlık Dalı

Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını,

---

[2] Özel hastaneler yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4'üncü maddesinde hasta yatak sayısı on olarak belirtilmekte ancak genel hastaneler başlıklı 6'ncı ve dal hastaneleri başlıklı 7'nci maddelerinde hastanelerin yoğun bakım ve gözlem yatağı hariç en az yirmi beş yatağa sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

4.26. Üremeye Yardımcı Tedavi Özel Merkezi

Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan merkezleri,

ifade eder.

II.BÖLÜM

ÖZEL HASTANE İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını

sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini

geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86. maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı

sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin

denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……’’

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin ‘Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri’ başlıklı 7’nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin ‘Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ başlıklı 13’üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler"

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Özel Hastane İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu

2.1.2. 3153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

2.1.3. 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

2.1.4. 922 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teammüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu

2.1.5. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

2.1.6. 2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun

2.1.7. 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

2.1.8. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

2.1.9. 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu

2.1.10. 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

2.1.11. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunun

2.1.12. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

2.2. Tüzükler

2.2.1. Özel Hastaneler Tüzüğü

2.2.2. Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Tüzük

2.2.3. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük

2.2.4. Tababet Uzmanlık Tüzüğü

2.2.5. Radyoloji, Radyon ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname

2.3. Yönetmelikler

2.3.1. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.2. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.3. Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

2.3.4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

2.3.5. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

2.3.6. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

2.3.7. Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik

2.3.8. Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik

2.3.9. Kaplıcalar Yönetmeliği

2.3.10. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

2.3.11. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

2.3.12. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.13. Özel Hastaneler Yönetmeliği

2.3.14. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği

2.4. Genelgeler

2.4.1. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Genelge-2006/104

2.4.2. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Genelge-2008/11-2008/17

2.4.3. Diyaliz-Organ Bağışı ve Kan Ürünleri Hakkında Genelge-2001/1

2.4.4. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge-19.09.2007

2.4.5. Ev Hemodiyalizi Hakkında Genelge-2007/30

2.4.6. Ebriyonik Kök Hücre Araştırmaları Hak.Genelge-2005-141

2.4.7. Gezici Sağlık Araçları ve Ünitelerinin Çalışma.Hak.Genelge-2004-83

2.4.8. Hasta Odalarının Düzenlenmesi Hak.Genelge-2007/44

2.4.9. Kök Hücre Çalışmaları Hak.Genelge-2006-51

2.4.10. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Hak.Genelge-2004-98

2.4.11. Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hak.Genelge-2005/180

2.4.12. Özel Hastaneler Hakkında Genelge-2002/70

2.4.13. Özel Hastanelerin Uzmanlık Dalı İlave işlemleri Hak.Genelge-2007/39

2.4.14. Özel hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Genelge 2008/10

2.4.15. Yoğun Bakım Üniteleri Standartları Genelgesi-2007-73

2.4.16. 3153-992 sayılı Kanun Kapsamındaki Laboratuarlar Hakkındaki Genelge-2007

2.4.17. Cerrahi Müdahale Birimlerinde Çalışacak Hekimler Hakkında Genelge-2001/68

2.4.18. Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi Hakkında Genelge-2007-68

2.4.19. Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge

2.4.20. Sağlık Kabinlerinin Açılışları ve İşleyişleri Hakkında Genelge 1997-03

2.5. Yönergeler

2.5.1. Böbrek Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.2. Doku Tipleme Laboratuarları Yönergesi

2.5.3. Elektro Konvülsif Tedavi Uygulama Yönergesi

2.5.4. İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

2.5.5. Kalp Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.6. Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.7. Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi

2.5.8. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler ve Diyaliz Merkezlerinin Ruhsatlandırılmasına Ait Yönerge

2.5.9. Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi

2.5.10. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

3. Özel Hastaneler Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

3.1. Özel Hastanelerin Açılması, Devri ve Kapatılması

Özel hastaneler; gerçek kişiler yada özel hukuk tüzel kişileri tarafından, en az yirmi beş yatak kapasitesi olarak, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbî müdahale, ameliyat, tıbbî bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilmek üzere açılır.

Özel hastane açmak isteyen kişilere özel hastaneler yönetmeliğinin 8'inci maddesinde belirtilen belgeleri ekleyerek yapacakları müracaata müteakip yapılacak inceleme sonucuna göre Sağlık Bakanlığı tarafından '**Ön İzin Belgesi'** verilir.

Ön İzin belgesi alan kişiler ön izin belgesi ve yönetmelikte (13'üncü maddede) belirtilen diğer belgelerin eklendiği hangi tür hastane açacaklarını belirtir bir dilekçe ile ilgili Valiliğe hastane açmak için başvururlar. Başvurunun İl sağlık Müdürlüğü tarafından incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi yada noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip başvuru Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru öncelikle genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir. Eksikliğin bulunmaması halinde Özel Hastaneler Teknik Komisyonuna havale edilir.

Komisyonun yapacağı İnceleme ve değerlendirme sonucunda eksik bulunmaması halinde komisyon hastaneyi yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar.

Bu inceleme sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye '**Ruhsatname**' düzenlenir. Genel Müdürlük ve Komisyon incelemelerinde görülen eksiklikler Valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilerek tamamlatılır.

Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra Yönetmelik ekinde bulunan kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlanarak müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından gerekli personeli tamamlandığı tespit edilen özel hastaneler, bu belgelerin tamamlanmasından itibaren Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça '**Faaliyet İzin Belgesi'** düzenlenir. Bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine başlar.

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir. (Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 9. ve 15.)

Faaliyete başlamış olan özel hastanelerde yeni uzmanlık dalı ilavesi durumunda yapılacak işlemler Sağlık Bakanlığı'nın 25.05.2007 tarih 39 sayılı Genelgesinde belirtilmiştir.

Buna göre Mesul Müdür ilavesi istenilen uzmanlık dalını belirtir dilekçesine genelgede belirtilen belgeleri ekleyerek İl Sağlık Müdürlüğüne başvuracak Müdürlük tarafından genelgede belirtilen incelemelerin yapılmasını müteakip Valilik oluru ile uzmanlık dalı eklenir. Eklenen uzmanlık dalının faaliyet belgesine işlenmesi için Valilik oluru ve faaliyet belgesi

(faaliyet belgesi düzenlenmemiş ise ruhsat) Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından yeni uzmanlık dalının faaliyet belgesine işlenmesi beklenilmeden Valilik oluru ile hastane yeni uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavi işlemlerine başlayabilir.

Özel hastaneyi devralan gerçek veya tüzel kişiler, devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devir halinde, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13., 14. ve 15'inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden devir alan adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğunda hastanenin faaliyeti devam eder.

Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi alınması şarttır. Devir işlemleri ve adres değişikliği işlemleri en geç altı ay içinde sonuçlandırılmaz ise Valilikçe özel hastanenin faaliyeti, işlemler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Özel hastaneler olağan dışı denetimler hariç altı ayda bir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenir.

3.1.1. Hastanenin Bir Bölümünde Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu

uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiğinde, çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar ilgili uzmanlık dalında,

Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbî donanımının eksik olduğu tespit edildiğinde, eksiklikleri giderilinceye kadar bu kliniklerin,

Faaliyet izin belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tespiti halinde faaliyet izin belgesine işleninceye kadar bu uzmanlık dalı veya dallarının,

Faaliyet izin belgesinde belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açıldığı takdirde, işlemleri tamamlanıncaya kadar ilave edilen klinik veya merkezlerin,

Uzman tabipler hariç olmak üzere, Yönetmelikte öngörülen asgarî sağlık personeli bulunmaması halinde,personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinceye kadar ilgili kliniklerde,

Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,

eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, Valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

3.1.2. Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatını de olumsuz etkilediği tespit edilir ise doğrudan Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın görüşü alınarak hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına Valilikçe eksikliğin giderilmesine kadar,

Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,

Özel hastaneler Yönetmeliğine göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuarlar ile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,

Bina içinde Özel hastaneler Yönetmeliğine uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,

Denetimde tespit edilen tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliklerin denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda giderilmediğinin tespiti durumunda bir aya kadar,

Kamu hastanesinde tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, devlet hizmet yükümlüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda bir aya kadar,

özel hastanenin tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

3.1.3. Hastanenin Kapatılması (Ruhsatın Geri Alınması)

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle Valilikçe faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanenin;

- Tespit edilen eksiklikleri altı ay içinde gidermemesi,

- Tamamında yada bir kısmında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanenin hasta kabule devam etmesi,

durumlarında hastanenin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır.

Hastanenin bir kısmında yada tamamında faaliyetin durdurulması yada ruhsatın geri alınması durumlarında mevcut hastalar müdürlükçe tespit edilerek bu hastaların tedavilerinin tamamlanmasından yada diğer hastanelere nakillerinin yapılmasından sonra hastanenin faaliyeti durdurulur.

3.1.4. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin Açılması, Devri, Kapatılması

Madde bağımlılığı tedavi merkezleri hastaneler bünyesinde veya sadece madde bağımlılığı tedavi usûlleri uygulamak amacıyla müstakil bir merkez olarak kurulabilir.

Müstakil olarak açılacak merkezler bakımından Bakanlıktan ön izin alınması gerekir. Gerekli projeler (Madde bağımlılığı tedavi merkezleri yönetmeliği 10. maddede belirtilen) eklenmiş başvuru müdürlük kanalıyla Bakanlığa gönderilir. Projelerde eksiklik bulunmaması durumunda bakanlık tarafından '**Ön İzin'** verilir.

Ön izin alınmasından sonra yönetmelikte (madde 10) belirtilen belgeleri ihtiva eden başvuru dosyasının eklendiği dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne ruhsat başvurusunda bulunulur. Başvuru sırası ile İl Sağlık Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Madde Bağımlılığı Tedavi Usûlleri Bilim Komisyonunu tarafından incelenir. Dosyadaki eksiklikler il müdürlüğü aracılığı ile tamamlatılır. Komisyon tarafından başvurunun uygun bulunmasını müteakip Bakanlık tarafından '**Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ruhsatnamesi'** düzenlenir.

Ruhsat sahibinin (madde bağımlılığı tedavi merkezinin devri) yada sorumlu hekimin değişmesi durumunda Bakanlıktan yeniden ruhsat alınması gerekmektedir.

Merkezler ihbar şikayet yada Bakanlık tarafından yaptırılan olağan dışı denetimler dışında yılda en az iki defa Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenir. Denetim sonucunda tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi için merkeze yazı ile ihtar verilip durum Bakanlığa bildirilir. Bu süre zarfında eksikliklerini veya tespit olunan usûlsüzlüğü gidermeyen merkez, ikisi Genel Müdürlükten ve üçü Komisyonun üyeleri arasından belirlenecek beş kişilik bir heyet marifetiyle yerinde denetlenir. Yapılan denetimde, eksikliğin veya usûlsüzlüğün devam ettiğine karar verilen merkezin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.

3.1.5. Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması

Organ ve Doku nakli merkezleri hastaneler bünyesinde bir ünite olarak kurulabilir. Ancak göz bankaları yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde kurulabilir. Bu nedenle göz bankalarına bu çalışmada yer verilmemiştir.

Organ ve Doku Nakli Merkezi açacaklar Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesinde belirtilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Sağlık Bakanlığına başvururlar.

Başvuru söz konusu yönetmeliğe göre oluşturulan nakli yapılacak organ yada doku ile ilgili Bilimsel Danışma Kurulu tarafından (Örn: Karaciğer nakli Merkezi için karaciğer nakilleri bilimsel danışma kurulu) değerlendirilerek hazırlanan rapor Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kuruluna sunulur. Başvuru Ulusal koordinasyon kurulunca uygun görüldüğü takdirde Bakanlık onayı ile '**Açılma İzni'** verilir. Merkezin sorumlu hekimi değiştiğinde açılma izni yenilenir.

Merkezler Ulusal Koordinasyon Kurulunun belirlediği kriterler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler ve faaliyetleri ulusal koordinasyon kurulu tarafından izlenip değerlendirilerek kendilerine uyarılarda bulunulur. Merkezlerin açılma iznine ait nitelikleri kaybetmeleri veya Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından faaliyetlerinin sakıncalı bulunması hallerinde çalışmaları Bakanlıkça durdurulur.

Böbrek nakli, karaciğer nakli, kemik iliği nakli ve kalp akciğer, kalp-akciğer homogreft nakli merkezlerinin ve doku tipleme laboratuarlarının açılması, çalışması, hizmetlerin

yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar Yönetmelikteki düzenlemelere paralel olarak ilgili yönergeler ile düzenlenmiştir.

3.1.6. Kordon Kanı Bankalarının Açılması, Devri, Kapatılması

Kordon kanı bankaları hastaneler yada dal hastaneleri bünyesinde bir ünite olarak kurulurlar. Kordon kanı bankası kurmak isteyen kişiler Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği 9'uncu maddesinde belirtilen belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile sağlık müdürlüğüne başvururlar.

Müdürlük yapacağı inceleme sonucunda varsa eksiklikleri tamamlatarak düzenleyeceği değerlendirme raporu ile dosyayı Bakanlığa gönderir.

Bakanlıkça Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulunun (UKOK) görüşünü alarak yapacağı inceleme neticesinde uygun bulunan başvuruya **'Kordon Kanı Bankası Çalışma Onayı'** verilir.

Kordon kanı Bankaları UKOK tarafından hazırlanan denetim rehberi çerçevesinde müdürlük tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Denetimde tespit edilen eksikliğin niteliğine göre bankaya eksikliğin giderilmesi için "2-6" hafta süre verilir. Eksikliğin giderilmemesi durumunda bankanın kordon kanı toplama biriminin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Bu aşamadan sonra eksikliğin "3" ay içinde giderilmemesi durumunda çalışma onay belgesi iptal edilerek bankadaki kordon kanı örnekleri ailenin onayı ile başka bir bankaya nakil edilir.

3.1.7. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde belirtilen belgelerin eklendiği dilekçe ile Valiliğe yapılan başvuru üzerine başvuru öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenerek Bakanlığa gönderilir. Başvuru Bakanlıkta oluşturulan Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonuna sunulur. Komisyon "30" gün içinde dosya incelemesi ve mahallinde yapacağı/yaptıracağı inceleme sonucunda başvurunun uygun bulunması durumunda merkez için Bakanlık tarafından **'Ruhsatname'** düzenlenir.

Yönetmeliğin 17'nci maddesinde belirtilen yasaklara uymayan, uygulamaları ve uygulama sonuçları Komisyon tarafından yeterli bulunmayan merkezlerin faaliyetleri komisyon görüşü ile Bakanlık tarafından üç aydan altı aya kadar durdurulur.

Durdurma süresi içinde yeniden başvurulur ise merkezin durumu değerlendirilerek çalışmasına izin verilir yada faaliyetin durdurulmasına devam edilir. Süre içinde başvuru olmaz yada yapılan incelemede merkezin durumunun değişmediği anlaşılır ise merkezin ruhsatı iptal edilir.

Merkezlerin şube irtibat bürosu yada hasta temin amacıyla yer açması yasaktır. Merkez ile tabip yada kuruluşlar arasında hastanın tabip seçme hakkını sınırlandıracak sözleşme yapılamaz. Bu hükümlerin ihlali durumunda merkezin ilk ihlalde üç ay, ikinci ihlalde altı ay faaliyeti durdurulur. Üçüncü ihlalde ise merkezin ruhsatı iptal edilir.

3.1.8. Ambulans Servislerinin Açılması, Devri, Kapatılması

Ambulans servisi kurmak için kuruluşun unvanının, sahip veya sahiplerinin, faaliyet adresinin, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların sınıfının belirtildiği dilekçe ile Müdürlüğe başvurur.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilmiştir. Müdürlük tarafından oluşturulacak komisyonun yapacağı inceleme neticesinde başvurusu uygun bulunan kuruluşa **'Ambulans servisi Uygunluk Belgesi'** ve ambulans servisinde bulunan her bir ambulans/acil sağlık aracına **'Ambulans Acil Yardım Aracı Uygunluk Belgesi'** düzenlenir.

Ambulans Servisini devir alan kişiler yönetmeliğin kuruluşla ilgili hükümlerinde (madde 9-11) belirtilen belgelerle yeniden Müdürlüğe başvururlar ve başvurularının incelenmesi sonucunda uygun bulunması halinde adlarına ambulans servisi uygunluk belgesi düzenlenir. Mevcut ambulans servisinin çağrı merkezi yada istasyonlardan birinin adres değişikliği yada ilave istasyon açılması durumunda yönetmeliğinin 11'inci maddesinde servisin yerine ilişkin belgelerle Müdürlüğe başvurulur.

Ambulans servisleri ihbar şikayet ve olağan dışı denetimler dışında yılda 2 kez Müdürlük tarafından denetlenir. Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için servise denetim formunda ilgili eksikliğin giderilmesi için belirlenen süreler verilir.

Ancak İl Tespit Komisyonunca belirlenen ücretlere uygun ücret uygulanmaması ve Mesul müdürlük belgesi olmaması durumlarının ikinci kez tespiti halinde ambulans servisi uygunluk belgeleri ile ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

3.1.9. Evde Bakım Merkez/Birimlerinin Açılması, Kapatılması

Evde bakım hizmeti sağlık kuruluşu (müstakil merkez yada hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi poliklinik gibi sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan birim) açacak olanlar dilekçe ile Sağlık Müdürlüğüne başvururlar.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmeliğin 9'uncu maddesinde belirtilen belgeler eklenir. Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülenlere **'Uygunluk Belgesi'** ve **'Mesul Müdürlük Belgesi',** sağlık kuruluşunun evde bakım hizmeti birimi olması halinde **'Birim Sorumlusu Belgesi'** düzenlenir.

Evde bakım sağlık kuruluşları (merkez, birim) ihbar şikayet ve olağan dışı denetimler dışında yılda iki defa (altı ayda bir) denetlenir. Denetimlerde kullanılacak formlarda tespit edilen eksikliğin giderilmesi için verilecek süreler belirtilmiştir.

Verilen sürede eksikliğin giderilmemesi durumunda yine formda belirtilen sürelerle faaliyet durdurulur. Faaliyetin süreli durdurulmasında süre sonunda, süresiz durdurulmasında ise üç ay içinde eksikliğin giderilmemesi halinde uygunluk belgesi iptal edilip geri alınır.

3.2. Özel Hastanelerde Görevlendirilecek Personeller

Sağlık mevzuatı gereğince özel hastanelerde sağlık hizmeti sunumu için görevlendirilecek personel ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

Personelin Unvanı ve Görevi	Aranılan Nitelikler
Hekim	Türkiye Darülfununu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olan T.C. vatandaşları (Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun madde 1)
Hemşire	Türkiye'de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olup diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilmek, öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ve 25.04.2007 tarih 5634 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden önce hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak yada kanunun yürürlük tarihinde bu programlarda kayıtlı bulunanlar (6283 sayılı Hemşirelik kanunu 1.madde,geçici 2. madde)
Uzman Hekim	Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne ekli Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olmak (Tıpta uzmanlık Tüzüğü madde 2.)
Tıbbî Teknisyen	İlgili Sağlık Meslek Okullarından veya Meslek Yüksek Okullarından mezun olmak
Mesul Müdür	Türkiye'de kamu yada özel en az beş yıl çalışmış ağır hapse yada yüz kızartıcı suçtan hapse mahkum

(Özel Hastane)	olmamış, Hususi Hastaneler Kanununun 38. ve 39. maddelerine göre mesul müdürlükten yasaklı olmayan tabip odasına kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekim olmak (Özel Hastane Yönetmeliği madde 16)
Mesul Müdür Yardımcısı (Özel Hastane)	Türkiye'de kamu yada özel en az beş yıl çalışmış ağır hapse yada yüz kızartıcı suçtan hapse mahkum olmamış, Hususi Hastaneler Kanununun 38 ve 39. maddelerine göre mesul müdürlükten yasaklı olmayan tabip odasına kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekim olmak (Özel Hastane Yönetmeliği madde 18/A)
Nöbetçi Tabip (Özel Hastane-Tıp Merkezi-Poliklinik)	1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olan nöbetler için mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstünde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, tam zamanlı veya kısmî zamanlı çalışan veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmî zamanlı çalışan tabipler (Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik madde 5.,21.,22.)
Diş Tabibi	1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olmak
Sorumlu Uzman (M.B.M.T.)	Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip (Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Yönetmeliği madde 30)
Hekim (M.B.M.T.)	Eğitim merkezinde altı ay süreyle madde bağımlılığı eğitimi görmüş ve bu merkezde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan hekimlere Bakanlıkça verilmiş Madde bağımlılığı eğitimi sertifikasına sahip (M.B.M.T.Yönetmeliği madde 30)

Psikolog (M.B.T.M.)	Eğitim merkezinde altı ay süreyle madde bağımlılığı eğitimi görmüş ve bu merkezde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan psikologlara Bakanlıkça verilmiş Madde bağımlılığı eğitimi sertifikasına sahip olmak (M.B.T.M. Yönetmeliği madde 30)
Hemşire (M.B.T.M.)	Merkezde çalışan hemşirelerden en az ikisi sertifika sahibi olmalıdır. Sertifika eğitim merkezinde üç ay süreyle madde bağımlılığı eğitimi görmüş ve bu merkezde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan hemşirelere Bakanlıkça verilir (M.B.T.M Yönetmeliği madde 30)
Doku Tipleme Laboratuar Sorumlusu	İmmünoloji Bilim Kurulunun kabul ettiği bir laboratuarda doku tipleme alanında en az iki yıl süre ile deneyimi olan ve bu eğitimi İmmunoloji Bilim Kurulu tarafından kabul edilen; ilgili mevzuata göre laboratuar açma yetkisini haiz uzman tabip yada immünoloji veya hematoloji dallarında üst ihtisas veya doktora eğitimi yapmış tabip olmalıdır (Doku Tipleme Laboratuarları Yönergesi madde 5)
Biyolog (D.T.L.)	4 yıllık biyoloji veya genetik dallarında öğrenim görmüş ve,Yönetmeliğe göre faaliyet izni almış Doku Tipleme Laboratuarlarında en az 6 ay süre ile serolojik ve moleküler biyoloji yöntemlerinde deneyim kazanmış olmak (D.T.L.Yönergesi madde 6)
Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu	Uzman olduktan sonra yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az 2 yıl deneyimli, bu sürede en az 50 böbrek naklinde aktif görev almış, bunların onda birini bizzat kendisi yapmış olduğunu ilgili kurumdan belgeleyen transplantasyon cerrahı (genel cerrahi veya üroloji uzmanı yada yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az 2 yıl deneyimli olan, bu sürede en az 100 böbrek nakilli hastanın ameliyat öncesi ve sonrası servis takibinde aktif görev alan ve

	bunu ilgili kurumdan belgelendiren nefrolog olmak.(Böbrek Nakli Merkezleri Yönergesi madde 5)
Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlusu	İki yıl süre ile senede 50 ve üstü veya bir yıl süre ile senede 100 ve üstü karaciğer nakli uygulayan bir merkezde aktif bir şekilde, sorumlu cerrah olarak çalışmış ve bu merkezden alacağı sertifika, Karaciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulları tarafından kabul edilmiş genel cerrah olmak (Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesi madde 5)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Karaciğer Nakli Merkezi)	Karaciğer nakli anestezisi ve yoğun bakımı konusunda tecrübeli anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak (Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)
Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer, Homogreft Nakilleri Merkezi Sorumlusu	Uzmanlıktan sonra en az 5 yıllık kalp cerrahisi tecrübesine haiz olup, aktif olarak yurt içi veya yurt dışında aktif bir kalp nakli merkezinde en az bir yıl çalışmış olan ve bu süre zarfında kalp nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığına dair ameliyat raporları ile hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığının belgelendiren kalp cerrahı olmalıdır (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 5)
Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahı	Merkez sorumlusu dışında en az iki Göğüs kalp damar cerrahı bulunmalıdır. (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)
Kardiyoloji uzmanı	En az 2 yıl invaziv ve noninvaziv kardiyoloji alanında deneyimli 2 kardiyoloji uzmanı ve transplantasyon konusunda aktif bir merkezde en az 3 ay çalışmış bir Kardiyoloji Uzmanı bulunmalıdır. (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon	Kardiyovasküler cerrahi konusunda deneyimli anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)
Patolog	Kalp ve akciğer transplantasyonu konusunda deneyimli bir patalog olmak (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)
İmmunolog	Birimi: Kalp ve akciğer transplantasyonu konusunda deneyimli bir immünolog olmak (Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi madde 6)
Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu	En az bir yıllık bir tecrübeye sahip olmak üzere; hematoloji, onkoloji uzmanı (çocuk üniteleri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı sonrası hematoloji, onkoloji veya immunoloji yan dal uzmanlığı olan) veya beş yıllık kemik iliği nakli deneyimine sahip iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak (Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi madde 7)
Hekim (Kemik İliği Nakli Merkezi)	Tam gün çalışan En az bir yıllık kemik iliği nakli deneyimine sahip hematoloji, onkoloji uzmanı veya en az iki yıllık kemik iliği nakli deneyimine sahip iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak (Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi m:7)
Hemşire (Kemik İliği Nakli Merkezi)	Merkezdeki hemşirelerden en az bir tanesi allogenik ve otolog kemik iliği nakli yapan bir merkezde en az altı ay eğitim almış olmalıdır (Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi madde 7)

Aferez Saklama Ünitesi İçin Hemşire - Teknisyen	Hemaferez konusunda en az altı ay deneyimli bir hemşire ve bir teknisyen olması(Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi madde 7)
Kordon Kanı Bankası Sorumlu Uzmanı	Tam gün esasına göre çalışan hematoloji veya çocuk hematolojisi uzmanı veya en az 2 yıllık hücre işleme ve saklama deneyimi olan veya açılacak sertifikasyon eğitimlerine katılarak yeterlik sertifikasına hak kazanmış klinik veya temel tıp bilimleri uzmanı hekimler olmak (Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği madde 11)
Hekim (Kordon Kanı Bankası Banka Ekibi)	Kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında eğitim görmüş sertifikalı bir hekim (Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği madde 12)
Laboratuar Teknisyeni (Kordon Kanı Bankası Banka Ekibi)	Kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında eğitim görmüş sertifikalı laboratuar teknisyeninden olmak (Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği madde 12)
Hekim (Kordon Kanı Bankası Kordon Kanı Toplama)	Kök hücre toplama konuda eğitim almış sertifikalı hekim olmak (Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği madde 13)
Hemşire – Sağlık Memuru (Kordon Kanı Toplama)	Kök hücre toplama konuda eğitim almış sertifikalı sağlık memuru ya da hemşire olmak (Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği madde 13)
Mesul Müdür (ÜYTE)	Tam gün süreli çalışan uzman yada pratisyen hekim olmak (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği madde 14,15)

ÜYTE Ünite Sorumlusu	Yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışında üreme, tıbbı infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az altı aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış, belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği madde 14,15)
Embriyoloji Laboratuarı Sorumlusu (ÜYTE)	Üremeye yardımcı tedavi konusunda yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışındaki merkezlerde en az altı aylık uygulamalı eğitim görmüş ve belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış tabip, histoloji-embriyoloji uzmanı veya histoloji-embriyoloji alanında üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda master veya doktora yapmış veteriner, biyolog, eczacı ve hemşire gibi bir sağlık personeli olmak (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği madde 14)
Mesul Müdür (Ambulans Servisi)	11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun hekim olmak (Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği madde 13)
Ambulans Sağlık Personeli	Ambulans ve acil bakım teknikerleri, anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenleridir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli; Bakanlıkça onaylanmış erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile

	tamamlamış ve sertifika almış olmak zorundadır (Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği madde 14, 15)
Şoför (Ambulans Servisi)	Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personeldir (Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği madde 4)
Mesul Müdür (Evde Bakım Merkezi)	11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun hekim olmak (Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik madde 11)

3.3. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

Özel hastanelerde istihdam edilen personelin iş ve ücret durumları hakkındaki bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

➢ Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile noter tasdikli mesul müdür ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmesi yapılır(Ö.H.Y. madde 13),

➢ Özel hastaneler faaliyet izin belgelerinde kayıtlı hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dallarının gerektirdiği sayı ve nitelikleri Özel Hastaneler Yönetmeliği (Ek-1) de belirtilen personeli kadrolu olarak (tam gün çalışma esasına göre) çalıştırmak zorundadır(Ö.H.Y. madde 19),

➢ Özel hastanelerde adlarına çalışma belgesi düzenlenmemiş tabip ve sağlık personeli çalıştırılamaz(Ö.H.Y. madde 66),

➢Özel hastanelerde personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri İl Sağlık Müdürlüğüne verilir(Ö.H.Y. madde 15),

➢Madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin açılışında görev yapacak personelin sözleşmelerinin noter tasdikli örnekleri İl Sağlık Müdürlüğüne verilir(M.B.TM.Y. madde 10),

➢Organ ve doku nakli merkezlerinde çalışacak personelin sözleşmelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile personelin eğitim durumlarını gösterir belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne verilir(O.D.N.M.Y. madde 18),

➢Kordon kanı bankalarında personelin sözleşmeleri ile eğitim uygunluğunu gösterir diploma, uzmanlık belgeleri, sertifika gibi belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne verilir(K.K.B.Y. madde 9),

➢Sağlık kuruluşunda nöbet hizmeti verilecek ise; nöbetçi tabibin çalışma belgesi mesul müdür tarafından düzenlenir. Ayrıca; haftalık nöbetçi tabip listesi hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır(Ö.H.Y. madde 17, Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge),

➢Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerinde çalışacak personelin sözleşmeleri ile eğitim uygunluğunu gösterir diploma, uzmanlık belgeleri, sertifika gibi belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne verilir(Ü.Y.T.M.Y. m:8),

➢Ambulans servislerinde çalışacak hekim ve diğer personel İl Sağlık Müdürlüğüne tarafından adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesi ile çalışabilirler (A.H.Y. madde 8),

➢Evde bakım merkezlerinde çalışacak personelin diploma ve nüfus cüzdanı örneklerinin İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesini müteakip müdürlük tarafından adlarına düzenlenen personel çalışma belgesi ile çalışabilirler (E.B.H.S.H.Y. madde 8),

➢Sözleşmelerde personelin yapacağı iş, sözleşmenin süresi, personelin çalışma durumu (tam zamanlı-kısmi zamanlı), aylık ücreti-saat ücreti, ücret dışında diğer ödemeler (hasta başına, prim, performans ödemeleri), sözleşmenin feshi ve uzatılması şartları belirtilir.

➢Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme formuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.

➢Özel hastaneler mevzuatında bu kuruluşlarda çalışacak personele ödenecek ücretle ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personele ödenecek aylık ücret miktarı 4857 sayılı İş Kanununa göre her yıl "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen asgarî ücretin brüt tutarının altında olamaz.

3.4. Özel Hastane Çalışanlarının Çalışma Saatleri

➢Özel hastane/dal hastanesi kadrolu personelinin haftalık çalışma süresi "45" saattir. Özel hastanelerde çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler(Ö.H.Y. madde 13),

➢2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4'üncü maddesinden yararlanarak kamuda kısmi zamanlı çalışan özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip sağlık personeli özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir.

➢Kısmi zamanlı çalışmalarda kısmi zamanlı çalışan personel ile yapılan iş sözleşmelerindeki çalışma süreleri dikkate alınır.

➢Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde hafta tatili dışında ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılması zorunludur. Bu kişilerin tam çalışması günlük "5" saattir. "5" saatlik çalışmanın sonrasında özel sağlık kuruluşunun başka işinde çalıştırılamazlar, ayrıca bu kişilerin senede kesintisiz dört hafta tatil yapmaları mecburidir(Radyoloji Radyon ve elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname madde 21).

3.5. Özel Hastanenin Çalışma Saatleri, Dönemleri

Özel hastane/dal hastanesinin ruhsat yada uygunluk belgesinde sağlık kuruluşunun çalışma saatleri belirtilmektedir. Sağlık kuruluşu belirtilen çalışma saatleri süresince hizmet vermek zorundadır. Özel hastanelerin günlük "24 saat" esasına göre çalışması esastır(Ö.H.Y. madde 17).

Diğer özel sağlık kuruluşları için kural olarak mesai saatlerinde çalışmak esastır. Ancak ruhsatlarında belirtilmiş olması durumunda "24 saat" kesintisiz faaliyette bulunmaları mümkündür.

3.6. Özel Hastanenin İl Sağlık Müdürlüğü Personeli ve Bakanlık Müfettişlerince Denetlenmesi

3.6.1. Özel Hastanelerin Denetimi

Özel hastaneler Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Özel Hastaneler Yönetmeliği ekinde yer alan "Ek-2 Özel Hastaneler Denetim Formuna" göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir. Bu denetimler dışında özel hastanelerde olağan ve olağan dışı olarak Bakanlıktaki Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu ve/veya Bakanlık Müfettişleri tarafından denetimler yapılabilir. Ayrıca şikayet üzerine özel hastanelerde inceleme ve soruşturma yaptırılabilir (Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 62).

Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Hastanenin, denetim sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ve usûlsüzlükler ile var ise öneriler, müdürlük tarafından rapor haline getirilerek denetimden itibaren en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Müdürlük denetim ekipleri tarafından tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, müdürlük tarafından hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir.

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usûlsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere bağlı kalınmak suretiyle, Valilikçe denetim formunda belirlenen işlemler uygulanır.

Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatını de olumsuz etkilediği tespit edilir ise, Valilikçe işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığa bildirilir.

Bu durumda, eksikliğin giderilmesine kadar hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına, Bakanlığın görüşü alınarak Valilikçe karar verilir.

Özel hastanelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için verilecek süreler ve bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar özel hastaneler yönetmeliği ekindeki özel hastaneler denetim formunda belirtilmiştir.

Özel hastanelerde faaliyetin süreli/süresiz, tamamında/ bir kısmında durdurulmasını gerektiren eksiklikler, bu eksiklikleri giderilmesi için verilen süreler ve uygulanacak cezalar Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 62., 63. ve 64.maddeleri ile Yönetmelik Ek-2 denetim formu birlikte değerlendirilerek aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Aşağıda sayılan faaliyet durdurma cezasını gerektiren fiiller dışında diğer eksiklikler için süreli olarak poliklinik hizmeti durdurma cezası uygulanmaktadır.

Tespit edilen Eksiklik	**Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilen Süre**	**Eksikliğin Devamında Uygulanacak-Verilecek Ceza**
1-Hastanenin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)	Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma

2-Acil ünitesi açık ve çalışır durumda değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
3-Acil ünitesinde yeterli uzman tabip ve diğer personel ile donanım hazır bekletilmiyor	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
4-Hastanede acil hastaların kabul ve sevk süreci tanımlanan bir düzenleme dahilinde uygulanmıyor	Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
5-Acil ünitesinde Yönetmeliğin 48'inci maddesinde belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutulmuyor	Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
6-Hasta nakil sürecinde hastanın gereksinimlerine uygun taşıma gerçekleştirilmiyor	Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
7-Hastanede hemşire çağrı sistemi yok	Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
8-Poliklinik muayene odalarında, Yönetmeliğin 48'inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutulmuyor	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma
9-Acil ünitesi ve acil hizmetler, Yönetmeliğin 26'ncı ve 39'uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma

10-Acil tabelası görülebilecek bir yerde asılı değil	Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma
11-Yönetmelik Ek-5 ve EK-6'daki tıbbî donanım ile ilaçlar yok	Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma
12-Ambulans hizmetleri 40'ıncı maddede belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 15 ay	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma
13-Ruhsatı ve faaliyet izin belgesine esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var	15 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
14-Müşterek teknik rapora uygun olmayan düzenlemeler var	15 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
15-İlgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış depreme dayanıklılık raporu yok	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
16-Hastanede grup/tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar var (iptal edilmiş yada ilave edilen üniteler, yatak sınıflarında değişiklik gibi)	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

17-Hastanede iletişimi sağlamaya yeterli telefon santrali yok	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
18-Hasta odaları, Yönetmeliğin 20'nci ve 22'nci maddeler ile belirlenen fiziki standartlara uygun değil	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
19-Tüm koridorlar, Yönetmeliğin 31'inci madde ile belirlenen standartlara uygun değil	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
20-Merdivenler, Yönetmeliğin 31'inci madde ile belirlenen standartlara uygun değil	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
21-Hastanedeki asansörler, Yönetmeliğin 31'inci maddesi ile belirlenen standartlara uygun değil	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
22-Yönetmeliğin 31'inci ve 34'üncü maddelerinde yer alan esaslara uygun olarak özürlülere ilişkin hastane girişinde, hasta katlarında, otoparkta, tuvalet ve banyolarda düzenlemeler yapılmamış	1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
23-Morg Yönetmeliğin 35'inci madde ile belirlenen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

24-Mutfak, Yönetmeliğin 36'ncı madde ile belirlenen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
25-Mutfak hizmeti dışarıdan satın alınıyor sözleşme yok	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
26-Mutfak hizmeti sözleşmesi yapılan şirkette görevli diyetisyen yok	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
27-Yemekhane, kantin, personel soyunma-giyinme odaları gibi çalışanların istirahatı ve ihtiyacı için ayrılan birimler yeterli değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
28-Besinlerin hazırlanması taşınması, depolanması ve dağıtımının güvenli olmasını sağlayan bir süreç yok	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
29-Çamaşırhane, Yönetmeliğin 36'ncı madde ile belirlenen standartlara uygun değil, hizmet dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme yok	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
30-Hastanenin içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmamış	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
31-Hastanenin mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatını da olumsuz etkiliyor		Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi

		bir aydan fazla süreli yada süresiz durdurulur
32-Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmamış		Yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
33-Özel hastaneler Yönetmeliğine göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuarlar ile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması		Bu eksiklikler giderilinceye kadar Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
34-Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda		Ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
35-Bina içinde Özel hastaneler Yönetmeliğine uygun olmayan bir değişikliğin bulunması		Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar
36-Denetimde tespit edilen tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliklerin denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda giderilmediğinin tespiti durumunda		Bir aya kadar hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

37-Kamu hastanesinde tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, devlet hizmet yükümlüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda		Bir aya kadar hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
38-Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için ayrılmış poliklinik muayene odası bulunmuyor	Mesul müdür uyarılır	Poliklinik odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur.
39-Poliklinik odası, Yönetmeliğin 23'üncü maddelerde belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Uygun Poliklinik odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur
40-Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, Yönetmeliğin 23'üncü maddede belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.
41-Üroloji polikliniği, Yönetmeliğin 23'üncü maddede belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.
42-Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24'üncü maddede belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta

		kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
43-Ameliyathanede hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut değil	Mesul müdür uyarılır	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
44-Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmamış (ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)	Mesul müdür uyarılır	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
45-Ameliyathanenin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla Enfeksiyon Koruma Yönergesi hazırlanmamış	Mesul müdür uyarılır10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
46-Ameliyathanenin işlem süreçleri yazılı olarak hazırlanmamış	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
47-Ameliyathanede, Yönetmeliğin 48'inci maddede belirtilen esaslara uygun kayıtlar tutulmuyor	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

48-Kullanılan anestezi ve anestezi tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına girilmiyor	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
49-Merkezî sterilizasyon ünitesi yok	1 ay süre	Cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
50-Yoğun bakım ünitesi Yönetmeliğin 25'inci maddede belirtilen standartlara uygun değil	Mesul müdür uyarılır	İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
51-Yoğun bakım ünitelerinde hepafiltreli havalandırma sistemi yok	Mesul müdür uyarılır 1 ay	Yoğun bakımlarda havalandırma sistemi kuruluncaya kadar İlgili uzmanlık dallarında yalnızca poliklinik hizmeti verilir
52-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen ÜYTE, diyaliz, organ ve doku nakli gibi merkezler, ilgili mevzuata uygun değil	Mesul müdür uyarılır	Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili merkezlerde faaliyet durdurulur
53-Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmuyor		İlgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar

54-Faaliyet izin belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tespiti halinde		Bu uzmanlık dalı veya dalları izin belgesine işleninceye kadar
55-Faaliyet izin belgesinde belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açılmış		İlave edilen klinik veya merkezlerin faaliyet izin belgesine işlenmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar
56-Uzman tabipler hariç olmak üzere, Yönetmelikte öngörülen asgarî sağlık personeli bulunmuyor		Personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinceye kadar ilgili kliniklerde
57-Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmemiş		Eksiklikler giderilinceye kadar, eksikliği tespit edilen birimin
58-Ameliyathanede atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanmıyor	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Ameliyathane faaliyetlerinin 3 gün durdurulması
59-Ruhsatlandırılmış bölümler dışında ek bina veya tesis var	Ek binada hizmet derhal durdurulur.	Ruhsat dışı kısımlarda hiç bir şekilde sağlık hizmeti sunulamaz

60-Merkezî tıbbî gaz sistemi yok	1 ay süre	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur
61-Yeterli güç ve nitelikte jeneratör yok	1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur
62-Hasta ve yakınlarının dinlenme ve sosyal faaliyetleri için ayrılmış alanlar yok	1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur
63-Yönetmeliğin 61'inci maddesinde yer alan dini görevlerin yerine getirilmesi için mekan ayrılmamış	1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur

54'üncü ve 55'inci maddelerde belirtilen hususlar 11/3/2009-27166 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tespit edilen eksiklikler nedeniyle faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanenin tespit edilen eksiklikleri altı ay içinde gidermemesi, tamamında yada bir kısmında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanenin hasta kabule devam etmesi durumlarında hastanenin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır.

3.6.2. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin Denetimi

Madde bağımlılığı tedavi merkezleri Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaptırılan şikayet ve soruşturma denetimleri dışında en az yılda iki defa denetlenir. Ayrıca

Bakanlık Madde Bağımlılığı Tedavi Usûlleri Bilim Komisyonuna denetim yaptırabileceği gibi Bakanlık Müfettişlerince de olağandışı denetimler yapılabilir.

Denetleme ekibi; merkezinin bulunduğu ilin sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı, yataklı tedavi kurumları şube müdürü, Bakanlığa bağlı hastanelerden il sağlık müdürlüğünce belirlenecek bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bir psikolog ile bir inşaat mühendisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Madde bağımlılığı tedavi merkezleri hastaneler bünyesinde veya sadece madde bağımlılığı tedavi usûlleri uygulamak amacıyla müstakil bir merkez olarak kurulabilirler.

Müstakil olarak kurulan özel merkezler, özel dal hastanesi hükmündedir ve bu merkezler hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel hastaneler ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu nedenle merkezlerin denetiminde Özel Hastaneler Yönetmeliği ekinde bulunan "Ek-2 Denetim Formu" kullanılır.

Denetim ile tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin bir ay içinde giderilmesi için Müdürlük tarafından merkez sorumlusuna yazılı ihtar yapılır.

Bu süre içinde eksiklik ve usulsüzlüklerini gidermeyen merkez, ikisi Genel Müdürlükten üçü komisyon üyeleri arasından belirlenen beş kişilik bir komisyonca yerinde denetlenir, eksiklik ve usulsüzlüğün devam ettiğine karar verilen merkezin ruhsatı geri alınır.

3.6.3. Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin Denetimi

Organ ve doku nakli yapılan merkezler yataklı tedavi kurumu olup hastane statüsünde olduklarından denetimleri özel hastanelerin denetimindeki usul ve esaslara tabidir.

Ayrıca merkezlerin faaliyetleri Ulusal Koordinasyon Kurulları tarafından izlenilip değerlendirilir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde merkeze Bakanlıkça yaptığı uyarılarla ilgili düzenlemeler merkez tarafından yapılmak zorundadır.

Merkezler özel hastanelerin kapatılması ile ilgili hususların yanı sıra açılma iznine ilişkin niteliklerini kaybettiklerinde ve kurul tarafından faaliyetlerinin sakıncalı bulunması durumlarında çalışmaları bakanlıkça durdurulur.

3.6.4. Kordon Kanı Bankalarının Denetimi

Bankalar, Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanacak olan denetim rehberine göre Müdürlüklerce en az yılda bir kez denetlenir.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için, eksikliklerin özelliğine göre, 2 - 6 hafta süre tanınır. Bu sürenin sonunda denetimde belirlenen eksikliklerin devamı halinde bankanın kordon kanı toplama biriminin faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

Bunu takiben 3 ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda bankanın Çalışma Onay Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilir.

3.6.5. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Denetimi

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde bu merkezlerin denetimlerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak bu merkezler İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından altı ayda bir denetlenmektedir. Denetimlerde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan denetim formları kullanılmaktadır.

Merkezlerin denetimi merkezle ilgili mevzuatta bulunmadığından müdürlükler denetimlerde tespit edilen eksiklikler için yaptırım uygulayamamakta, tespitleri Bakanlığa bildirip gelen cevaba göre işlem yapmaktadırlar.

3.6.6. Ambulans Servislerinin Denetimi

Ambulans servisleri ile ambulans ve acil sağlık araçları; İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans servisi ile ambulans ve acil sağlık araçlarının incelenmesi, teftiş ve denetimi için müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli bir hekim ve en az iki sağlık personelinden oluşturulan komisyonca düzenli olarak yılda en az iki kez denetlenir.

Şikayet ve soruşturma ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine olağan dışı denetimler yapılır.

Denetim sonuçları teftiş ve denetim defterine yazılıp genel müdürlüğe bildirilir. Ayrıca Bakanlık tarafından denetim yapılabilir.

Denetimlerde ambulans servisleri için örneği Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ekinde bulunan "EK-10/A Ambulans Servisi Denetleme Formu", ambulans ve acil sağlık araçları için "EK-10/B Ambulans/Acil Sağlık Aracı Denetleme Formu" kullanılır ve bu formlarda belirlenen yaptırımlar uygulanır.

Ambulans servislerinde tespit edilen eksikliklerde verilen süre içinde eksikliğin giderilmemesi durumunda faaliyetin geçici durdurulması cezası uygulanır.

Ancak aşağıda belirtilen eksikliklerin ikinci kez tespiti durumunda uygunluk belgeleri iptal edilir;

➢Mesul müdürlük belgesinin olmaması ve ambulans ücretleri il tespit komisyonunun belirlediği ücretlere uygun uygulama yapılmaması durumunda ambulans servisi uygunluk belgesi ve ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

➢Aşağıdaki eksikliklerin ikinci kez tespitinde ambulans uygunluk belgelerinin iptali gerekmektedir.

1-Ambulans/acil sağlık aracının sınıfına uygun personelin olmaması,

2-Ambulans/acil sağlık aracında çalışan tüm personelin çalışma izin belgesinin olmaması,

3-Ambulans/acil sağlık aracında çalışan personelin yönetmelikte belirtilen kurslara ilişkin kurs belgelerinin olmaması,

4-Ambulans/acil sağlık aracında bulunması zorunlu hekim sağlık personeli yerine öğrenci stajyer çalışıyor olması,

5- Ambulans/acil sağlık aracının yönetmelikte belirtilen teknik ve tıbbi özelliklere uygun olmaması,

6-Ambulans/acil sağlık aracında yönetmelikte belirtilen tıbbi cihaz araç, gereç ve ilaçların bulunmaması,

7-Ambulans/acil sağlık araçlarının amacı dışında kullanılması.

3.6.7. Evde Bakım Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşlarının Denetimi

Evde bakım hizmeti sunan Sağlık kuruluşlarının denetimi; bir hekim, bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık personelinden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilir.

Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, en az altı ayda bir olağan denetimler yapılır.

Denetimlerde ilgili Yönetmelik ekinde bulunan "Ek-7 Denetleme Formu" kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır.

Hekim dışı sağlık personeli tarafından hastaya verilen evde bakım hizmetlerinin denetimi Müdürlük tarafından görevlendirilecek bir sağlık personeli başkanlığında; tabip odası temsilcisi ile hekim dışı sağlık personelini temsil eden derneklerden bir temsilciden oluşturulacak bir ekip ile denetlenir.

Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler

hariç olmak üzere en az üç ayda bir, her bir sağlık kuruluşu tarafından en az iki hastaya verilen hizmet yerinde denetlenir.

Denetimlerde kullanılacak formlarda tespit edilen eksikliğin giderilmesi için verilecek süreler belirtilmiştir. Verilen sürede eksikliğin giderilmemesi durumunda yine formda belirtilen sürelerle faaliyet durdurulur.

Faaliyetin süreli durdurulmasında süre sonunda, süresiz durdurulmasında ise üç ay içinde eksikliğin giderilmemesi halinde uygunluk belgesi iptal edilip geri alınır.

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler, dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, özel hastane/dal hastanesi işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip özel hastane/dal hastanesinin faaliyet konusu ile hasta kabul ve tedavi edebileceği uzmanlık dalları, hasta yatak sayısı, vermekte olduğu laboratuar hizmetleri, özel hastanenin dışarıdan temin edebileceği hizmetlerin (laboratuar, tıbbi sterilizasyon, ambulans, yemekhane, çamaşırhane, güvenlik, temizlik vb.) dışarıdan temin edilmesi yada kendi çalışanlarınca yapılması, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (hekim, sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özel hastane/dal hastanesi işyerinde ikmal edilen işin yürütümü şartlarının tespiti için İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare özel hastane/dal hastanesi işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (hekim, sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler vb.) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Özel hastane/dal hastanesi işyerleri asgarî işçilik incelemesinde, hizmet sunumuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden istenecek izin/uygunluk belgeleri, personel sözleşme ve izin belgeleri, bilgi ve envanter formaları ile denetim raporları ve ekleri bulunmaktadır.

Özel hastane/dal hastanesi işyeri hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden istenecek belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-3).

İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilecek bilgi yada belgelerden işin yürütüm şartları ile çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır.

Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Özel hastane/dal hastanesi işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî -azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan talimatlara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar

Yapılacak asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanakları (EK-2) asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

Özel hastane/dal hastanesinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanağında;

- İşverenin adı-soyadı-unvanı, işyeri adresi, işyerinde yapılan iş, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü, işyeri sicil numarası bilgileri,
- Özel hastane açma izin yazısının (ön izin, ruhsat/uygunluk belgesi) tarih ve sayısı, Kurum açma izin tarihi, faaliyet izin belgesinin tarih ve sayısı,
- Özel hastane hasta muayene ve kabule yetkili olduğu uzmanlık dalları,
- Özel hastanenin kuruma ait ruhsat yada uygunluk belgesi dışında birim ve üniteler için alınan ruhsat/uygunluk belgelerinin tarih ve sayısı ve bu birim, ünitelerin faaliyete başlama tarihleri,

- Özel hastanenin temin ettiği (varsa) laboratuar, röntgen, ambulans, yemekhane, çamaşırhane, temizlik, güvenlik işlerine ait firma bilgileri ve sözleşme tarihleri,

- İşyerinde yönetici olarak çalışan personelin sayısı ve unvanları (Mesul Müdür, Mesul Müdür Yardımcısı, Hemşirelik müdürü….vb.),

- İşyerinde çalıştırılan (pratisyen hekimler dahil) hekimlerin uzmanlık dallarına göre sayıları, kadrolu yada part-time çalışma esasları,

- İşyerinde çalıştırılan sağlık personelinin sayısı, kadrolu ve part time çalışma durumları ile diğer personelin (hastabakıcı, büro personelleri, hizmetli, bekçi, aşçı, garson, güvenlik,temizlik v.b.) sayıları,

- (Varsa) Şirket ortağı ve işverenin ücretsiz çalışan eşi bilgileri,

- Özel hastanelerin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, gözlem yatak sayısı ile bunların toplamından oluşan hastane yatak sayısı, yatak sayısının kaçının ücretsiz hastalar için ayrıldığı ve denetim tarihinde yatan hasta sayısı,

- Kullanımı eğitimli personel tarafından gerçekleştirilen tıbbi cihazlara ait bilgiler (Örneğin kemik iliği ve kordon kanı bankalarındaki kemik iliği ve kök hücre dondurma saklama ünitelerindeki cihazlar yada hiperbarik oksijen tedavisi basınç odaları gibi),

denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek tutanağa alınacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Özel hastane/dal hastanesi işyerinin açılması, durdurulması, kapanması, tüm faaliyetleri II.Bölümde belirtilen Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelere istinaden yürütülmektedir.

Hastaneler belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili belgeleri düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, özel hastane/dal hastanesinin faaliyetleri kapsamında tabi olduğu mevzuat gereği düzenlemek ve İl Sağlık Müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş özel hastane/dal hastanesi tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine verilen ve yukarıda sayılan kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

1. İl Sağlık Müdürlüklerine Verilmesi Gereken Belgeler

1.1. Ön İzin Belgesi, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Özel hastaneler kuruluşlarında ön izin belgesi almak zorundadır. Ayrıca ;

▪ Başka amaçla inşa edilmiş binaların, hastane binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,

▪ Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değişiklik yapılması durumunda,

▪ Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hastane binasında, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,

▪ Ruhsatlandırılmış hastane binasına, Özel hastaneler yönetmeliği Ek-4'üncü maddedeki planlamaya uygun olmak şartıyla, ilave bina yapılmak istenmesi halinde, ön izin alınması zorunludur.

Ön İzin başvurusunda aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

✓Başvuru dilekçesi,

✓İki takım mimari proje,

✓Hastane binasının bulunduğu alanın, aşağıda belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

• İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olması,

• Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunu tespit eden Valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu,

• Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının belgeleyen ilgili belediye yazısı,

- Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunu belgeleyen İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu,

- Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, Mahalli İdarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki sağlık yapıları ile ilgili ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrıldığının mimari proje ile belgelenmesi,

✓Mimari proje içinde ayrıca aşağıdaki belgeler yer alır.

- 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,

- 1/100 veya 1/150 ölçekli tüm katlar planları,

- Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm cepheler, yatak kapasitesi 50 ve üzerinde olanlar için bir tanesi de önem arz eden rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen en az üç kesit.

Özel hastane açmak için ön izin belgesi alanlar, Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili Valiliğe başvururlar.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

✓Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

✓Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre Belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya

1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,

✓İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,

✓Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

✓Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği veya Vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği,

✓Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi alındısı,

✓İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,

✓Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin Noter tasdikli örneği,

✓Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait Ticaret Odası faaliyet belgesi,

✓Özel hastaneler yönetmeliği EK-3'e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,

✓Özel hastaneler yönetmeliği EK-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi.

✓Mesul Müdür ve Mesul Müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere;

- Özel hastanede Mesul Müdür ve Mesul Müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair noter tasdikli Mesul Müdürlük ve Mesul Müdür yardımcılığı sözleşmeleri,

- Türkiye'de iki yılı kamu yada özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

- Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

- Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

- Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

- Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

- Adlî sicil kaydı,

- Tabip odası kayıt belgesi.

İl Sağlık Müdürlüğünce incelenen başvuruda eksiklik bulunmaması durumunda aşağıdaki belgelerin eklendiği başvuru bakanlığa gönderilir.

- İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

- İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

- Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Özel Hastaneler Yönetmeliği EK-9'a uygun olarak müştereken

düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Özel hastaneye ruhsat verilmesinden itibaren özel hastaneler yönetmeliği Ek-1'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri, özel hastane tarafından tamamlanarak müdürlüğe verilir.

Müdürlük tarafından gerekli personeli tamamlandığı tespit edilen özel hastaneler, bu belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bütün bu işlem ve işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıkça, özel hastaneler yönetmeliği Ek-7'de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine başlar.

1.2. Özel Hastanelerin Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

Özel hastanelerin gerçek ve tüzel kişilere devir edilmesi halinde yukarıda belirtilen ruhsat ve faaliyet izin belgesi alınması için gerekli belgeler devir alandan alınarak müdürlük ve Bakanlık tarafından yapılacak işlemler yapılıp devir alan adına yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Özel hastaneler yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış ve denetimlerinde eksiklik ve usulsüzlük bulunmayan hastanelerin fiziki yapısında ve türünde değişiklik yapılmadığı Müdürlük tarafından tespit edilen hastanelerin devrinde ise yukarıda belirtilen işlemler yaptırılmayıp devir işleminin

yapıldığını gösteren belge ve devir alan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi ve belgeler müdürlüğe verilir.

Müdürlükçe son altı ay içinde yapılmış denetime ilişkin rapor dikkate alınarak eksiklik bulunmaması halinde başvuru Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça devir alan adına ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

1.3. Mesul Müdür Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefâtı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde özel hastaneler yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeleri Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir. Gerekli belgeler şunlardır.

✓Özel hastanede Mesul Müdür ve Mesul Müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair noter tasdikli mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri,

✓Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

✓Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

✓Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

✓Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

✓Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

✓Adlî sicil kaydı,

✓Tabip odası kayıt belgesi,

1.4. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi alınması şarttır. Yukarıda özel hastanelerin ruhsat alması bölümünde belirtilen tüm işlemlerin yapılıp belgelerin verilmesi gerekmektedir.

1.5. **Uzmanlık Dalı, Tıbbi Hizmet Birimi İlavesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler**

✓İlavesi istenilen uzmanlık dalının ve yoğun bakımların isimlerini belirten hastane mesul müdürlüğünün talep dilekçesi,

✓İlavesi istenilen uzmanlık dalında kamuda çalışmayan ve tam gün esasına göre çalışma saatleri belirtilerek düzenlenmiş uzman hekim ile yapılmış sözleşme aslı veya onaylı örneği ile onaylı diploma örneği,

✓İlavesi istenilen uzmanlık dalının gerektirdiği diğer personele ait sözleşmeler ve onaylı diploma örnekleri,

✓İlavesi istenilen uzmanlık dallarının veya yoğun bakım ünitelerinin özel hastaneler yönetmeliği "Ek-3 Tıbbi Araç Listesine" göre düzenlenmiş ve hastane Mesul Müdürlüğünce onaylanmış tıbbi araç gereç listesi,

✓Hastane ruhsatına esas onaylı proje ile ilgili Belediye tarafından onaylı iki takım mimari proje (ilavesi istenilen uzmanlık dalı veya yoğun bakım ünitelerinin tesis edildiği yeni düzenlemeyi gösteren),

✓Faaliyet İzin Belgesi (Henüz faaliyet izin belgesi düzenlenmemiş olanlar için ruhsat).

1.6. **Özel Hastanelerde Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler**

Özel hastanelerin mesul müdür ve mesul müdür yardımcıları için Sağlık Müdürlüğüne verilecek belgeler yukarıda belirtilmiştir. Bu kişiler dışındaki personelle ilgili olarak müdürlüğe personel ile yapılan sözleşmenin aslı yada mesul müdür tasdikli örneği verilmek zorundadır.

2. İl Sağlık Müdürlüklerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

2.1. İncelenecek Kayıt ve Belgeler

Özel hastane/dal hastanesi işyerleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle(EK-3) istenilecektir.

İl Sağlık Müdürlüğüne verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-7) gösterilmektedir. Sözkonusu belgeler;

✓Ön izin, ruhsat, faaliyet izin belgesi tesis izin belgesi, işletme izin belgesi ve uygunluk belgesi,

✓Mesul müdür/sorumlu uzman sözleşmeleri,

✓ Mesul müdür/sorumlu uzman belgeleri,

✓ Personel sözleşmeleri ve ilgili evraklar

✓ Personel çalışma izin belgeleri,

✓ Denetim raporları ve ekleri

✓ Müdürlüğe verilen bilgi ve envanter formları,

✓ Sağlık personeli dışında çalışan personelin isim listeleri,

✓ Aylık olarak il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğüne verilen acil servis nöbet listeleridir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilen kayıt ve belgeler, özel hastane işyerinin açılış, hasta kabul ve tedaviye başlama tarihleri, kapasitesi ve diğer genel özellikleri ile işyerinde çalıştırılan mesul müdür, mesul müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, baş hemşire, hemşire, sağlık memuru, ebe, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, psikolog, tıbbi teknisyen, acil tıp teknisyeni-teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, hastane hizmetli personeli (hasta bakıcı) memur, hizmetli ve benzeri çalışanların işyerinde çalışmaya başladıkları ve işyerinden ayrıldıkları tarihler ile unvanları, ücret durumları, kimlik bilgileri ve diğer kişisel özelliklerinin tespitine yönelik olarak incelenmektedir. Bahse konu belgelerden;

Özel Hastane Ruhsatnamesi, Uygunluk Belgesi ve Faaliyet İzninden;

Özel hastanenin adı, adresi, sahibinin adı/unvanı, ruhsat/uygunluk belgesi/faaliyet izin belgesi tarih-numarası, faaliyete başlama tarihi, çalışma saatleri, mesul müdürün adı-

soyadı, hasta kabul ve tedaviye yetkili olduğu uzmanlık dalları, hasta/yoğun bakım/gözlem/ücretli-ücretsiz yatak sayıları, sözleşme ile satın alınan hizmetler,

Özel Hastane Çalışan Personelin İş Sözleşmelerinden;

İşveren Kurum ve kurucusuyla ilgili bilgiler, görev alan personelin adı-soyadı, ev adresi, görevin çeşidi, çalışma şekli (kadrolu-part time) ücreti (aylık ücreti/part time çalışanlarda saatlik ücreti) ücret dışında yapılan ödemeler, sözleşmenin tanzim tarihi, sözleşmenin (görevin) başlama tarihi, sözleşmenin bitim tarihi, terfi süresi, zam nispeti, sözleşmeyle ilgili genel şartlar ve sözleşmenin fesih şartları,

Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık Denetim elemanları ve Bakanlık Müfettişlerinin Denetimleri Sonucu Düzenledikleri Rapor ve Eklerinden;

Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık Denetim elemanları ve Bakanlık Müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucu düzenledikleri rapor ve eklerinden denetim günü sağlık kuruluşunda çalıştırıldığı tespit edilen kişiler, bu kişilerin adı-soyadı, sağlık kuruluşundaki görevi, tespit edilebilir.

Özel hastane/dal hastanesi işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu çalıştırılan personellerle ilgili olarak; adı-soyadı, T.C. kimlik no veya sigorta sicil no, işyerindeki görevi (mesul müdür, mesul müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, baş hemşire, hemşire, sağlık memuru, ebe, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, psikolog, tıbbi teknisyen, acil tıp teknisyeni-teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, hastane hizmetli personeli (hasta bakıcı), vb.), iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre işe başlama ve işten ayrılma tarihleri, fiilen

işten ayrılma tarihi, çalışma şekli (tam zamanlı/kısmi) kısmi çalışmanın şekli ve ücretlendirilmesi hakkında tespit edilen bilgiler için "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-6) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Hastanelerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Protokol Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Adli Rapor Kayıt Defteri	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Laboratuar Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Pansuman ve Enjeksiyon Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Denetim ve Teftiş Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 62, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

	Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Cerrahi Müdahale Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde

Protokol kayıt defteri; özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar ve ameliyathane gibi tıbbî hizmet ünitelerinde, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi,yaşı,cinsiyeti, tanı, karar, düşünceler, muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu sağlık kuruluşunun hangi kliniğinde (tıp dalında) veya bölümünde kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Adli rapor kayıt defteri; hastane tarafından düzenlenen adli raporların tümünün kayıt edildiği, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih ve saat, adı ve soyadı, adresi, yaşı, cinsiyeti, başvuru şekli, tanı ve karar, muayeneyi yapan ve Adli Raporu düzenleyen hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü yer alır.

Laboratuar kayıt defteri; özel hastanelerin her bir laboratuar birimi için, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı,cinsiyeti, istenen tetkik,

sonuçlar, tetkiki isteyen hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu sağlık kuruluşunun hangi laboratuar biriminde kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri; özel hastanede gerçekleştirilen tüm enjeksiyon, pansuman ve benzeri işlemler için her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı,cinsiyeti, yapılan işlem, işlemi yapan sağlık personelinin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylayan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Denetim ve teftiş defteri; özel hastanede Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için kullanılan her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylayan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Cerrahi müdahale kayıt defteri; özel hastaneye başvuran hastalara yapılan cerrahi müdahalelerin işlendiği, sağlık müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş, tutulması zorunlu defterlerdendir.

1.2. Tutulmazı Zorunlu Belgeler

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları(İş Sözleşmesi)	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Hasta Dosyası	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 48
Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi,	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 13
Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri Ve Sözleşmeleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 13
Personel Çalışma İzin Belgeleri, Sözleşmeleri ve İlgili Evrakları	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 15
Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personelin İsim Listeleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 15
Denetim Raporları ve Ekleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 62, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge

	(2006-104)
Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları,	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Aylık Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Fişi	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Hemşire Gözlem Kağıdı	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Taburcu Muayene Bulguları Formu	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Tıbbi Müdahale Raporu	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 17
Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri	Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge (2005-180)

Hasta dosyası içerisinde, asgarî olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

- Hasta kabul kâğıdı,
- Tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı,
- Hasta tabelası,
- Derece kâğıdı,
- Röntgen istek kâğıdı ve tetkik raporları,
- Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik raporları,
- Ameliyat kâğıdı,

- Hastanın muayene istek formu,
- Çıkış özeti,
- Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu (değişik 13.04.2003/ 25078).

2. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-4) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-5) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Özel hastane/dal hastanesi işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-6) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Özel hastane/dal hastanesi işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,
- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,
- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,
- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,
- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,
- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

Özel hastane/dal hastanesi işyeri işvereninin sağlık mevzuatı gereği tutmak zorunda olduğu ve yukarıda sayılan defterlerin incelenmesi sırasında ise;

- Noterden veya benzeri bir kuruluştan tasdik zorunluluğu bulunmayan bu defterlerin, Sağlık Müdürlüğünce yada özel sağlık kuruluşunun mührüyle tasdik edilip edilmediği,

- Özel hastane/dal hastanesinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, eğitim durumu, özel sağlık kuruluşundaki görevi, işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, ayrıma nedeni, izin kullanma durumu, gibi hususlarla ve sağlık kuruluşunda hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarında personel istihdam edilip edilmediği,

- Gerekli görülen diğer konular,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç

tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden özel hastane/dal hastanesinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel hastane/dal hastanesi işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Özel Hastane/Dal Hastanesi İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Özel hastanenin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri

doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel hastanenin devir edilmesi halinde ise, devir işleminin sağlık müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinden, Kurumumuza devir bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinin; devir işlemi sırasında düzenlenmesi gereken "devir senedi" incelenerek bu belgelerde yazılı devir tarihi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri

2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu

Özel hastane işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının "bağımlılık esasına dayalı" olarak ortaya konulması gerekmektedir.

2.1.1. Tam/Kısmi Zamanlı Bağımlı Çalışanlar

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesine göre; bir kişinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı olabilmesi için bir veya birkaç işverenin yanında (tam/kısmi zamanlı) çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Özel hastane işyerlerinde işin yürütüm şartları gereği tam zamanlı çalışma esası uygulanmakla birlikte özellikle bazı nitelikli personelin kısmi zamanlı çalıştırılması da söz konusu olabilmektedir. Kısmi çalışan bu kimseler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sigortalı değiller

ise Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

2.1.2. Şirket Ortaklarının Çalışması

Doktor olarak çalışsalar bile özel hastane/dal hastanesi ortakları (şirket ortağı olmadan önce 5510 sayılı kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı olup halen devam edenler hariç olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

2.1.3. Serbest Çalışan Hekimden Hizmet Satın Alma

Özel hastaneler tarafından, muayenehanesi olup serbest çalışan hekimlerden hizmet satın alma sözleşmesi ile hasta muayene ve tedavi hizmetlerini satın almaları durumuna rastlanılmaktadır.

Söz konusu sözleşmenin tarafı olan hekimin sigortalılık durumunun (bağımsız çalışan olup 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendine yada hizmet akdine istinaden çalışıp aynı maddenin (a) bendine mi tabi olacağının) tespiti gerekmektedir.

Bu durumda tarafların sözleşmeye verdikleri isme bakılmaksızın hekimin çalışmalarının niteliği çerçevesinde hizmet akdinin belirleyici unsuru olan bağımlılık unsurunun oluşup oluşmadığı tespit edilerek bağımlılık unsurunun tespit

edilmesi halinde bu kişilerin hizmet akdine istinaden çalıştığının kabulü gerekmektedir.

2.1.4. 2368 Sayılı Kanuna Tabii Olanların Serbest Çalışmaları

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinde özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olan sağlık personelinin Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen tazminat haklarından yararlanmamak şartıyla mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecekleri belirtilmektedir.

Özel Kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip sağlık personeli hekim, diş hekimi, ebe hemşire ve sağlık memuru'dur.

Kamuda çalışan meslek ve sanatını serbest icra etme hakkına sahip bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (c) bendine göre sigortalı olacaklardır. 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı olan kişilerin özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışmaları halinde Kurumumuz uygulamaları bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları olanaklı değildir. Çalışan kişinin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre zorunlu sigortalı olması halinde de aynı durum söz konusudur.

2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Sigortalıların işe giriş tarihleri düzenlenen iş sözleşmeleri, İl Sağlık Müdürlüklerine verilen belgeler ile Kurumumuza yapılan bildirimler karşılaştırılmak suretiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen işe başlama tarihi ile Kurumumuza yapılan bildirim mutabık değil ise ilgili kişinin ifadesinin alınması ve işyeri kayıtları incelemesi dahil bağımlılık esasına dayalı çalışmanın başlama tarihi tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirlenecektir.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün

sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir(Yönetmelik 4'üncü madde).

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır(SSİY. 108/3 Madde).

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinde "24" saat boyunca hizmet verilmektedir. Uygulamada çoğu zaman gündüz yapılan normal çalışma sürelerinin dışında kalan sürelerin "15-16" saatlik (gündüz çalışmanın "8-9" saatlik olasına bağlı olarak) nöbetler şeklinde çalışıldığı, acil servis ve ambulanslarda "24" saatlik nöbet uygulamalarının olduğu görülmektedir.

Bu durum hastanenin bazı çalışanlarının haftalık "45", aylık "180" saatlik çalışma sürelerinin üzerinde çalışmasına neden olmaktadır. Söz konusu fazla çalışmaların aylık yada haftalık nöbet listelerinden tespit edilerek fazla çalışma ücretlerinin İş Kanunu ve ilgili mevzuata göre tahakkuk ettirilip prime esas kazanç olarak bildirilip bildirilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla İl Sağlık Müdürlüğünden istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, işveren ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte özel hastane/dal hastanesi işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter (Denetim ve Teftiş Defteri, Protokol Defteri vb.) ve belgelerle (Personel Çalışma Belgesi, Haftalık Nöbet Çizelgeleri, Ücret Ödeme Belgeleri vb.) de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında özel hastane/dal hastanesi işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte özel hastane/dal hastanesi işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti halinde, konu mutlaka Sağlık Bakanlığına intikal ettirilmelidir.

Yukarıda belirtilen nöbet listelerinden kayden tespit edilen fazla mesailer asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Özel hastane/dal hastanesi işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması;

Özel sağlık kuruluşunun hasta kabul ve tedaviye yetkili olduğu uzmanlık dalları, hasta yatak sayısı, özel sağlık kuruluşunun asıl ruhsatı (hastane yada tıp merkezi gibi) yanı sıra almış olduğu ruhsat uygunluk belgesi ve açılma izinleri, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (uzman hekim, hekim, diğer sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Özel hastanelerin tabi olduğu mevzuat hükümlerinde bu kuruluşların cinsi ve niteliğine göre çalıştırılması gereken asgarî sağlık personeli sayısı belirtilmektedir. Personel sayısı sağlık kuruluşları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Asgarî işçilik incelemesinde; çalıştıkları kayden/fiilen tespit edilen kişilerin nitelik ve sayılarının, hastanenin türü ve asıl faaliyet ruhsatı dışında sahip olduğu ruhsat ve belgeler dikkate alınarak belirtilen nitelik ve sayılara uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.

4.2.1. Özel Hastaneler

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 15'inci maddesinde faaliyet izin belgesinin alınabilmesi için özel hastanelerin ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren, Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek-1'de gösterilen tam zamanlı çalışan personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve

personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlanarak müdürlüğe verileceği belirtilmektedir. Bu hükme göre özel hastanelerde asgarî Yönetmeliğin ekinde bulunan listedeki nitelik ve sayıda personel çalışması gerekmektedir. Bu liste aşağıda gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
I-UZMAN TABİP	
A-Genel hastaneler	
a) 10-29 hasta yatağı arası (asgarî 4 ayrı uzmanlık dalında)	4
b) 30- 49 hasta yatağı arası (asgarî 4 ayrı uzmanlık dalında)	6
c) 50 hasta yatağı ve üzeri için (asgarî 4 ayrı uzmanlık dalında)	8
B- Dal hastaneleri	
a) 10-29 hasta yatağı arası (ana uzmanlık dalında)	2
b) 30- 49 hasta yatağı arası (ana uzmanlık dalında)	3
c) 50 hasta yatağı ve üzeri için (ana uzmanlık dalında)	4
d)Faaliyet göstereceği uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dallarında	1
C- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (part time)*	
*Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartı ile	
a) Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her genel hastane için 99 hasta yatağına kadar	1
b) 100 hasta yatağı ve üzeri için ayrıca	1
c) Cerrahi uzmanlık dallarını içeren dal hastanelerinde	1
d) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve dahili uzmanlık dallarını içeren dal hastanelerinde EKT ünitesi için	1

D- Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı *	
*Hastane bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.	
a) Genel veya dal hastanelerinde	1
E- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı	
*Hastane bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.	
a) Genel veya dal hastanelerinde	1
F- Patoloji Uzmanı	
a) Patoloji laboratuarı bulunan hastanelerde	1
G- Hematoloji uzmanı	
a) Hematoloji ve onkoloji uzmanlık dallarının bulunduğu dal hastanelerinde	1
b) Hematoloji uzmanlık dalı bulunan genel hastanelerde	1
H-Radyodiagnostik Uzmanı	
*Hastane bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.	
a) Genel veya dal hastanelerinde	1
II-TABİP*	
a) 10- 29 hasta yatağı arası hastaneler için	2
b) 30 ilâ 49 hasta yatağı arası hastaneler için	3
c) 50 yatak ve üzeri hastaneler için	4
*Pratisyen tabip yerine aile hekimliği uzmanı, acil tıp uzmanı veya dal hastanelerinde hastanenin hizmet sunduğu ana uzmanlık dalından aynı sayıda uzman tabip, genel hastanelerde hastane faaliyetine uygun uzmanlık dallarında aynı sayıda uzman tabipler çalıştırılabilir.	
III- DİŞ TABİBİ	
a) Her diş üniti için	1
IV-BAŞHEMŞİRE	
a)Her sağlık kuruluşu için	1

V-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU* (*Kadın sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ebe çalıştırılabilir.)	
a) Servisler için her 5 hasta yatağa	1
b) Yoğun bakım ünitelerinde 1 yoğun bakım hasta yatağa	2
-Sonraki her yoğun bakım hasta yatağı için	1
c) Ameliyathanelerde	
-Her ameliyat masası için	2
d) Doğum kliniğinde 5 bebek hasta yatağı için*	2
*Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi	
-İlave her 3 bebek yatağı için	1
e) Rehabilitasyon merkezi konuşma tedavi bölümünde	1
f) Gözlem odası için her 3 hasta yatağa	1
g) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde her üç poliklinik için	1
h)Adli tıp polikliniği için	1
VI- EBE	
a) Doğum salonunda her doğum masasına*	1
*Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış	
VII- ECZACI	
a) 50 yatak ve üzeri her hastane için	1
VIII-FİZYOTERAPİST	
a) Her nöroloji servisi için	
b) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlık dalında her 10 yatak için	1
IX- DİYETİSYEN*	
a) Her hastane için	1
* Hizmet alımı yolu ile dışarıdan yemeğini temin eden hastanelerde mutfak hizmetlerinin satın alındığı şirkette istihdam edilen diyetisyenin sözleşme örneğinin verilmesi kaydıyla aranmaz.	

X-PSİKOLOG	
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı bulunan genel hastanelerde	1
XI-ODYOLOG	
-Odyoloji laboratuarı bulunan sağlık kuruluşunda	1
XII-TIBBİ TEKNİSYENLER	
a) Anestezi teknisyeni, her anestezi cihazı için	1
b) laboratuar teknisyeni, her laboratuar için	1
c) Röntgen teknisyeni,	
-Her röntgen teşhis cihazı için	1
d) Diş protez teknisyeni (diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için)	1
XIII- ACİL TIP TEKNİSYENİ/ TEKNİKERİ	
a) Her ambulans için	1
b) Acil servislerde	
- 10-49 hasta yatağı arası	2
- 50 ve üzeri her 30 hasta yatağı için	2
XIV-FİZİK MÜHENDİSİ	
a) Radyoterapi uzmanlık dalı bulunan hastaneler için	1
XV-DİĞER PERSONELLER	
a) Aşçı (Yemekhane hizmetlerinin sözleşme ile alınması halinde aranmaz.)	1
b) Biyomedikal mühendisi veya elektrik mühendisi veya elektronik mühendis	
-100 hasta yatağı ve üzeri	1
c) Sosyal hizmet uzmanı	
- Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde her 30 yatak için	1
- İlave her 30 yatak için	1
d) Hastane hizmetli personeli	
- Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde her 5 hasta yatağı için (en az iki hafta süre ile hizmet içi hasta bakıcılığı eğitimi almış)	1

e)Güvenlik görevlisi	
- Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta katı için	1
- Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesi için	2
NOT: -Uyku laboratuarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman doktoru haricinde çalışacak doktorun sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.	

Ayrıca yönetmelik ekindeki asgarî personel listesi dışında Özel Hastaneler Tüzüğünde bulunan (1) sayılı çizelgede de özel hastanelerin personel sayıları belirtilmiştir. Özel Hastaneler Tüzüğünün, Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre daha eski tarihli olması ve düzenlemelerin yetersiz kalması nedeniyle tüzük uygulamada yer bulamamaktadır. Bu nedenle tüzükteki personel sayıları yönetmelikte değinilmemiş olan hastane hizmetlileri itibariyle dikkate alınmıştır.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
HİZMETLİ	
Her 5 yatak için	1
Çocuk ve doğum hastanelerinde her 4 yatak için (kadın)	1
Kronik hastalıklar hastanelerinde her 8 yatak için	1
Hematoloji ve immunoloji laboratuarında her laboratuarı için	1
Röntgen tedavi laboratuarı için	1
Bakteriyoloji laboratuarı için	1
Biyokimya laboratuarı için	1
Endeskopi laboratuarı için	1
Hormon laboratuarı için	1
Yoğun bakım ünitesi için (Her iki yatak için ayrıca)	5(1)

Merkezi sterilizasyon bölümü için	2
Kan nakil merkezi için	2
Patolojik anatomi laboratuarı için	1
Rehabilitasyon merkezi egzersiz ve fizik uygulamalar bölümünde her 10 yatak için	1
ŞOFÖR (Her hastaneye)	1
ERKEK ÖLÜ YIKAYICI (50 yataktan yukarı her hastaneye)	1
KADIN ÖLÜ YIKAYICI (100 yataktan yukarı her hastaneye)	1

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklikleri düzenleyen, 11.03.2009 tarih 27166 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren yönetmelik ile özel hastanelerin asgarî çalışacak personel sayılarını gösterir (Ek.1) liste yeniden düzenlenmiştir. Belirtilen yeni liste aşağıdadır.

I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.
II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir.
III-UZMAN TABİP Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgarî altı klinik uzman tabip Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgarî dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip
IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman

V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
IX- TABİP Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.
X-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi

XI-BAŞHEMŞİRE Her hastane için bir başhemşire
XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Her beş hasta yatağı için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki, -Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, -Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir), -İlave her üç bebek yatağı için en az bir, -25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.
XIII-EBE Her doğum masası için en az bir
XIV-ECZACI 50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir
XV-FİZYOTERAPİST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)
XVI-DİYETİSYEN Her hastane için en az bir
XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER -Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir, -Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir, -Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir

XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1
XIX-DİĞER PERSONEL Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,
NOT: -Uyku laboratuarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

4.2.2. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilen personel nitelik ve sayıları ile bu merkezlerde bulunması zorunlu laboratuar ve birimler ile madde bağımlılığı tedavi merkezlerin özel hastanelerin bünyesinde kurulabilmesi, müstakil merkezlerin dal hastanesi olması nedeniyle Özel Hastaneler Yönetmeliği ek-1 de bulunan asgarî personel nitelik ve sayıları çerçevesinde merkezlerin asgarî personel durumu aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca merkezin müstakil olmayıp özel hastanenin ünitesi olması durumunda yukarıda özel hastanelerle ilgili belirtilen personel nitelik ve sayıları dikkate alınacaktır.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
SORUMLU UZMAN (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı)	1
UZMAN HEKİM (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı) -Her 10 yatak için	1
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI (Part Time)*	
*Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartı ile	1
BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI	1
HEMATOLOJİ UZMANI	1
RADYODİAGNOSTİK UZMANI	
HEKİM	

(altı ay süre ile madde bağımlılığı eğitimi görerek, bu konuda sertifika almış olan aile hekimliği uzmanı veya pratisyen tabip)	
a) İlk 10 yatak için	5
b) İlave her on yatak için	1
PSİKOLOG Altı ay süre ile madde bağımlılığı eğitimi görerek bu konuda sertifika almış ve klinik tecrübesi olan	1
BAŞHEMŞİRE	1
HEMŞİRE En az ikisi eğitim merkezinde üç ay süre ile madde bağımlılığı eğitimi görmüş ve yapılan teorik-pratik sınavlarda başarılı olarak sertifika almış	
a) İlk on yatak için	6
b) İlave her on yatak için	4
ECZACI 50 yatak ve üzeri için	1
FİZYOTERAPİST	1
DİYETİSYEN* Hizmet alımı yolu ile dışarıdan yemeğini temin eden hastanelerde mutfak hizmetlerinin satın alındığı şirkette istihdam edilen diyetisyenin sözleşme örneğinin verilmesi kaydıyla aranmaz	1
TIBBİ TEKNİSYENLER	
a) Anestezi teknisyeni, her anestezi cihazı için	1
b) laboratuar teknisyeni, her laboratuar için	1
c) Röntgen teknisyeni, Her röntgen teşhis cihazı için	1
AŞÇI (Yemekhane hizmetlerinin sözleşme ile alınması halinde aranmaz.)	1
SOSYAL HİZMET UZMANI	
- İlk 30 yatak için	1
- İlave her 30 yatak için	1
HASTANE HİZMETLİ PERSONELİ	
Her 5 hasta yatağı için (en az iki hafta süre ile hizmet içi hasta bakıcılığı eğitimi almış)	1

GÜVENLİK GÖREVLİSİ	
- hasta katı için	1
- acil ünitesi için	2
STERİLİZASYON PERSONELİ	2

4.2.3. Organ ve Doku Nakli Merkezleri

Organ ve doku nakli merkezleri esas itibariyle Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre kurulup ruhsatlandırılmış hastaneler bünyesinde kurulabilmektedir. Yukarıda özel hastanelerin personel niteliği ve sayıları ile ilgili yapılan açıklamalar bünyesinde organ ve doku nakli merkezi bulunan hastaneler içinde geçerlidir.

Bu merkezler özellik arz etmeleri nedeniyle bünyesinde bulundukları hastanede belli ünitelerin kurulmuş olması dolayısıyla belli nitelikteki personelin istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Bünyesinde organ ve doku nakli merkezi bulunan bir hastanenin asgarî işçilik incelemesi yapılırken bu merkezlerin personel nitelik ve sayılarının yukarıda açıklanan özel hastanelerin personel nitelik ve sayıları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

4.2.4. Böbrek Nakli Merkezleri

Böbrek Nakli Merkezleri Yönergesinde belirtilen personel ve merkezde bulunması gereken üniteler çerçevesinde bünyesinde böbrek nakli merkezi kurulu olan özel hastanenin merkezle ilgili personel nitelik ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Yönergede bulunması zorunlu olarak belirtilen birimler için personel sayısı 1 olarak gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	SAYISI
Merkez Sorumlusu (Transplantasyon cerrahı yada Nefrolog olabilir) -Merkez sorumlusu olacak transplantasyon cerrahının (genel cerrahi veya üroloji uzmanı), uzman olduktan sonra yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az 2 yıl deneyimli olması, bu sürede en az 50 böbrek naklinde aktif görev almış olması, bunların onda birini bizzat kendisinin yapmış olduğunu ilgili kurumdan belgelemesi gerekmektedir - Merkez sorumlusu olacak nefrologun, yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az 2 yıl deneyimli olması, bu sürede en az 100 böbrek nakilli hastanın ameliyat öncesi ve sonrası servis takibinde aktif görev almış olması ve bunu ilgili kurumdan belgelendirmesi gerekir.	1
Transplant Cerrahı (genel cerrahi veya üroloji uzmanı),	1
Nefrolog	1
Radyolog	1
Patolog (transplantasyon konusunda deneyimli)	1
Mikrobiyolog	1
Transplantasyon koordinatörü	1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı	1
İç hastalıkları Uzmanı	1
Çocuk sağlığı ve hastalıkları Uzmanı (çocuk böbrek nakli merkezlerinde)	1
Biyolog	1
Mikrobiyolog	1
Anestezi teknisyeni	1
Hemşire	En az 5
Tıbbi Teknisyen (Her laboratuar için)	1
Tıbbi sekreter	1
Kan Merkezi Personeli (aynı şehirde olmak kaydıyla, gerektiğinde kan ürünü temin edebileceği bir kan bankası ile işbirliği anlaşması belgelendiği	1

takdirde aranmaz.) Kan Merkezi Kurulması zorunlu olduğunda Uzman Hekim Laboratuar Teknisyeni	1
İmmünolog veya böbrek nakli merkezinde immünolog yok ise aynı şehirde olmak kaydıyla 24 saat destek verecek immünolog olmalıdır.	1
Doku tipleme laboratuarı personeli (nitelik ve sayıları aşağıda doku tipleme laboratuarı bölümünde açıklanacaktır) -Ruhsatlı doku tipleme laboratuarından hizmet alınacağı belgelendiği takdirde laboratuar bulunması zorunlu değildir.	
Diyaliz Ünitesi Personeli (nitelik ve sayıları aşağıda diyaliz merkezleri bölümünde açıklanacaktır) -Hastane bünyesinde diyaliz merkezi yok ise en az iki cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi bulundurmalıdır.	
Yoğun Bakım Ünitesi Personeli Hemşire her hasta yatağı için Hizmetli -Her iki yatak için ayrıca	 2 5 2

4.2.5. Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri

Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesinde belirtilen personel ve merkezde bulunması gereken üniteler çerçevesinde bünyesinde kalp, akciğer, kalp-akciğer ve homogreft nakli merkezi kurulu olan özel hastanenin merkezle ilgili personel nitelik ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Yönergede bulunması zorunlu olarak belirtilen birimler için personel sayısı (1) olarak gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	SAYISI
Merkez Sorumlusu (Kalp Cerrahı) Uzmanlıktan sonra en az 5 yıllık kalp cerrahisi tecrübesine haiz olup, aktif olarak yurt içi veya yurt dışında aktif bir kalp nakli merkezinde en az bir yıl çalışmış olması ve bu süre zarfında kalp nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığına dair ameliyat raporları ile hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığının belgelendirilmesi gereklidir.	1
Uzman Hekim (Kalp Cerrahı) Kalp cerrahisi uygulamalarında en az 3 yıl deneyimli, yılda en az 200 açık kalp cerrahisi yapıyor olan ve kadrolu çalışan olmalıdır.	2
Uzman Hekim (Kardiyoloji Uzmanı) - 2 si En az 2 yıl invaziv ve noninvaziv kardiyoloji alanında deneyimli - 1'itransplantasyon konusunda aktif bir merkezde en az 3 ay çalışmış -Pediatrik transplantasyon yapacak merkezlerde çocuk kardiyologu olmalıdır.	3
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı (Kardiyovasküler cerrahi konusunda deneyimli)	1
Mikrobiyoloji Uzmanı (Mikrobiyoloji laboratuarı her türlü mikrobiyolojik ve serolojik tetkiki yapma olanağına sahip olmalıdır)	1
Biyokimya Uzmanı (biyokimya laboratuarı ilaç düzeylerini ölçebilecek kapasitede olmalıdır.)	1
Patoloji Uzmanı (Kalp ve akciğer transplantasyonu konusunda deneyimli)	1
İmmünoloji Uzmanı (Kalp ve akciğer transplantasyonu konusunda deneyimli)	1
Göğüs hastalıkları Uzmanı	1
Tıbbi Teknisyen (Her laboratuar için)	1
Psikolog	1

Sosyal Hizmet Uzmanı	1
Fizyoterapist	1
Organ ve Doku nakli Koordinatörü	1
Organ doku nakli dökümantasyon birimi personeli	
Kan Merkezi Personeli	
Yoğun Bakım Ünitesi Personeli Hemşire her hasta yatağı için Hizmetli -Her iki yatak için ayrıca	2 5 2

4.2.6. Karaciğer Nakli Merkezleri

Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesinde belirtilen personel ve merkezde bulunması gereken üniteler çerçevesinde bünyesinde karaciğer nakli merkezi kurulu olan özel hastanenin merkezle ilgili personel nitelik ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Yönergede bulunması zorunlu olarak belirtilen birimler için personel sayısı (1) olarak gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
Merkez Sorumlusu (Genel cerrah) Cerrahi girişim ve uzun dönem takip dahil karaciğer nakli verici-alıcı programını yönetebilecek meslekî birikime sahip, iki yıl süre ile senede 50 ve üstü veya bir yıl süre ile senede 100 ve üstü karaciğer nakli uygulayan bir merkezde aktif bir şekilde, sorumlu cerrah olarak çalışmış olmalı ve bu merkezden alacağı sertifika, Karaciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulları tarafından kabul edilmiş olmalıdır	1
Uzman Hekim (Genel Cerrah) Alıcı ve verici ekip için birer kişi	2
Gastroenteroloji Uzmanı	1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı (Karaciğer nakli anestezisi ve yoğun bakımı konusunda tecrübeli)	2
Kardiyoloji Uzmanı	1
Radyoloji Uzmanı	1

Patoloji Uzmanı	1
Mikrobiyoloji Uzmanı	1
Biyokimya Uzmanı	1
Organ ve Doku nakli Koordinatörü	1
Nefroloji Uzmanı	1
Yoğun Bakım Ünitesi Personeli Hemşire her hasta yatağı için Hizmetli -Her iki yatak için ayrıca	 2 5 2
Hemodiyaliz Servisi Personeli (nitelik ve sayıları aşağıda diyaliz merkezleri bölümünde açıklanacaktır)	
Kan Merkezi Personeli (Bünyesinde kan merkezi bulunmayan hastaneler, aynı şehirde olmak şartıyla gerektiğinde kan ürünü temin edebileceği bir kan merkezinden hizmet alacağını belgelemelidir)	

4.2.7. Kemik İliği Nakli ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri

Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesinde belirtilen personel ve merkezde bulunması gereken üniteler çerçevesinde bünyesinde kemik iliği nakli merkezi ve kemik iliği nakli doku bilgi işlem merkezi kurulu olan özel hastanenin merkezle ilgili personel nitelik ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Yönergede bulunması zorunlu olarak belirtilen birimler için personel sayısı (1) olarak gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
Merkez Sorumlusu En az bir yıllık tecrübeye sahip hematoloji, onkoloji uzmanı, (Çocuk üniteleri için hemotoloji, onkoloji veya immunoloji yan dal uzmanlığına sahip çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) veya beş yıllık kemik iliği nakli deneyimine sahip iç hastalıkları yada çocuk hastalıkları uzmanı	1

Uzman Hekim Hematoloji, onkoloji uzmanı(en az bir yıl kemik iliği nakli deneyimine sahip) İç Hastalıkları Yada Çocuk Hastalıkları Uzmanı (en az iki yıl kemik iliği nakli deneyimine sahip)	1
Hemşire En az birisi allogrenik ve otolog kemik iliği nakli yapan bir merkezde altı ay eğitim almış olmak şartıyla vardiya başına her üç yatağı için bir	En az 4
Aferez ve Saklama Ünitesi Personeli Hemşire (Hemaferez konusunda en az 6 ay deneyimli) Teknisyen (Hemaferez konusunda en az 6 ay deneyimli)	 1 1
Doku Tipleme Laboratuarı Personeli (nitelik ve sayıları aşağıda doku tipleme laboratuarı bölümünde açıklanacaktır) -Ruhsatlı doku tipleme laboratuarından hizmet alınacağı belgelendiği takdirde laboratuar bulunması zorunlu değildir	
Sitogenetik Laboratuarı Personeli -Ruhsatlı sitogenetik laboratuarından hizmet alınacağı belgelendiği takdirde laboratuar bulunması zorunlu değildir.	
Hematoloji ve Biyokimya laboratuarı Bu laboratuarlar 24 saat hizmet vermelidir bu nedenle her bir laboratuar için Uzman Hekim Tıbbi Teknisyen	 1 4
Histopatoloji Uzmanı	1

Radyoloji Uzmanı	1
Mikrobiyoloji Uzmanı	1
Tıbbi Teknisyen Histopataloji, radyoloji ve Mikrobiyoloji için	1'er
Eczacı	1
Tüm ana uzmanlık dallarında uzman hekim (göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, nefroloji, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, beyin cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, vasküler ve genel cerrahi, çocuk kemik iliği transplantasyonu üniteleri için çocuk cerrahisi ve diğer çocuk üst uzmanlık alanları)	1'er
Yoğun Bakım Ünitesi Personeli Hemşire her hasta yatağı için Hizmetli -Her iki yatak için ayrıca	 2 5 2
Kan Merkezi Personeli	1

4.2.8. Doku Tipleme Laboratuarı

Doku Tipleme Laboratuarları Yönergesinde belirtilen personel nitelik ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	SAYISI
Laboratuar Sorumlusu Doku tipleme alanında en az iki yıl süre ile deneyimi olan ve bu eğitimi İmmunoloji Bilim Kurulu tarafından kabul edilen; ilgili mevzuata göre laboratuar açma yetkisini haiz uzman hekim, immünoloji veya hematoloji dallarında üst ihtisas veya doktora eğitimi yapmış hekim olmak (yetişmiş eleman sıkıntısı nedeniyle kamuda çalışan doku tipleme laboratuarı sorumlusunun aynı zamanda bir özel laboratuarın sorumlusu olması mümkündür)	1
Biyolog Faaliyet izni almış bir doku tipleme laboratuarında en az altı ay serolojik ve moloküler biyoloji yöntemlerinde deneyim kazanmış	1
Tıbbi Teknisyen	2
Tıbbi Sekreter	1

4.2.9. Kordon Kanı Bankaları

Kordon kanı bankaları hastanelerin bünyesinde bir ünite olarak kurulabilirler. Bu nedenle bünyesinde kordon kanı bankası bulunan bir özel hastanenin asgarî işçilik incelemesi yapılırken organ ve doku nakli merkezlerinde olduğu gibi sadece bu bölümde belirtilen personel ve nitelikleri değil yukarıda değinilen Özel Hastaneler Yönetmeliği ek-1 de bulunan personel nitelik ve sayıları dikkate alınmalıdır. Burada kordon kanı bankası nedeniyle çalışması gereken nitelik olarak özellik arz eden personele değinilecektir.

NİTELİĞİ	SAYISI
Banka Sorumlu Uzmanı Hematoloji veya çocuk hematolojisi uzmanı veya en az 2 yıllık hücre işleme ve saklama deneyimi olan veya açılacak sertifikasyon eğitimlerine katılarak yeterlik sertifikasına hak kazanmış klinik veya temel tıp bilimleri uzmanı hekim	1
Kordon kanı Toplama ekibi Kordon kanı toplama konusunda eğitim almış hekim, sağlık memuru yada hemşire	2
Banka Ekibi Hekim Kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında eğitim görmüş sertifikalı hekim	1
Laboratuar Teknisyeni Kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında eğitim görmüş sertifikalı laboratuar teknisyeni	1

4.2.10. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri

Üremeye yardımcı tedavi merkezleri hastane bünyesinde bir ünite şeklinde kurulabileceği gibi müstakil merkez olarak ta kurulabilir. ÜYTE'nin hastane bünyesinde ünite şeklinde kurulmuş olması durumunda yukarıda özel hastaneler bölümünde belirtilen nitelik ve sayıda personelin bulunup

bulunmadığı kontrol edilecek ayrıca ÜYTE ünitesi için bu bölümde belirtilen nitelik ve personelin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

NİTELİĞİ:	**SAYISI**
Mesul Müdür Müstakil merkezlerde bulunması zorunludur. Hastane bünyesinde ünite olarak faaliyet gösteren merkezlerde bulunmasına gerek yoktur. Tam gün çalışan pratisyen yada uzman hekim olabilir.	1
ÜYTE Ünite Sorumlusu Müstakil merkez ve hastane ünitesi için zorunludur. Yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışında üreme tıbbı, infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az altı aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış, belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, müstakil merkezin Mesul müdürü bu niteliklere sahip ise ayrıca ünite sorumlusuna gerek yoktur, Mesul Müdür her iki görevi birlikte yürütür.	1
Uzman Hekim Üroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum	1
Embriyoloji Laboratuarı sorumlusu Üremeye yardımcı tedavi konusunda yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışındaki merkezlerde en az altı aylık uygulamalı eğitim görmüş ve belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış tabip, histoloji-embriyoloji uzmanı veya histoloji-embriyoloji alanında üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda master veya doktora yapmış veteriner, biyolog, eczacı ve hemşire gibi bir sağlık personeli,	1
Anestezi Uzmanı	1
Tam Donanımlı Bir Ambulans Personeli (Personel nitelik ve sayısı aşağıda Ambulans servisleri bölümünde	

açıklanacaktır.) -Ambulans hizmetleri veren bir kurumla ameliyathanede yapılacak her müdahale süresince ambulans bulundurulmasına dair anlaşma yapılması durumunda ambulans bulundurma ve ambulans personeli çalıştırma zorunluluğu aranmaz.	
Endokrin ve Androloji laboratuarı Merkezde veya aynı ilde merkezle bağlantısı olan, hasta takibi için gerekli hormon çalışmalarının yapılabildiği ve gerekli araç, gereçle donatılmış bir endokrin laboratuarı ile merkez içinde androloji laboratuarı ve personeli Her Laboratuar için Uzman Hekim Laboratuar Teknisyeni	 1 1
Ameliyathane Personeli (Ameliyathane hemşiresi, Anestezi teknisyeni, hizmetli)	Yeterli sayıda en az 1 er
Diğer sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık memuru, Ebe, Laboratuar ve Rontgen teknisyeni, Hizmetli..)	Yeterli sayıda en az 1 er
İdari Personel	Yeterli sayıda

Yönetmelikte ameliyathane personeli, diğer sağlık personeli ve idari personel için sayı belirtilmemiş yeterli sayıda ibaresine yer verilmiştir. Merkezin büyüklüğü ve Özel Hastaneler, Ayaktan Teşhis Tedavi Merkezler Yönetmelikleri çerçevesinde bu personel için merkezde bulunması gereken sayı tespit edilmelidir. Ayrıca personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim almış olmaları gerektiği ve bu eğitimleri ile ilgili sertifika ve belgelere sahip olmaları gerektiği hususları dikkate alınmalıdır.

4.2.11. Ambulans Servisleri

Özel sağlık kuruluşları ambulans bulundurdukları takdirde ambulans uygunluk belgesi almak zorundadırlar.

Ambulans servis olarak kurulan özel sağlık kuruluşu en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır.

Ambulans servisi ve ambulanslarda bulunması gereken sağlık personeli nitelik ve sayısı aşağıda gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	**SAYISI**
Mesul Müdür Hekim yada uzman hekim olmak. Mesul Müdür yada Mesul Müdüre vekalet eden hekim ambulans hekimi olarak çalışamaz.	1
AMBULANS PERSONELİ KARA AMBULANSLARI	
Acil yardım ambulansı Hekim veya Ambulans ve Acil bakım teknikeri Sağlık Personeli Şoför	**3** 1 1 1
Özel donanımlı ambulans Hekim Sağlık Personeli Şoför	**3** 1 1 1
Hasta Nakil Ambulansı Sağlık Personeli Şoför	**2** 1 1
Hava Ve Deniz Ambulansı Hekim Sağlık Personeli Hava/Deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personel	**3** 1 1 1

Ambulans servisinde görev yapacak sağlık personeli yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarına, şoför ise temel ilkyardım eğitimi sertifikasına sahip olmalıdır.

"24 saat" faaliyet gösteren ambulans servislerinde personelin nöbet aralarındaki süre en az "48 saat" olmalıdır. Bu durumda her ambulans için "3" ekip çalışması gerekmektedir. Nöbet listeleri mesul müdür tarafından aylık hazırlanır ve saklanır.

4.2.12. Evde Bakım Merkez ve Birimleri

Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşları müstakil merkez olarak kurulabileceği gibi hastane, tıp merkezi, dal merkezi yada poliklinikler bünyesinde birim olarak da kurulabilirler. Aşağıda belirtilen personel nitelik ve sayıları evde bakım merkez-biriminde çalışması gereken personelin nitelik ve sayılarıdır. Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşunun hastane tıp merkezi dal merkezi yada poliklinik bünyesinde bulunması durumunda ilgili sağlık kuruluşları için belirtilen personelin yanı sıra bu bölümde belirtilen nitelik ve sayıda personelin çalışması gerekmektedir.

NİTELİĞİ:	**SAYISI**
Mesul Müdür (Evde bakım merkezi); Hekim olmak.	1
Birim Sorumlusu; Hekim olmak. Evde bakım biriminin bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun mesul müdürü aynı zamanda bu birimin birim sorumluluğunu yapabilir.	1
Hekim; Mesul müdür veya birim sorumlusu dışında en az bir tanesi tam zamanlı çalışan hekim.	2
Hemşire veya sağlık memuru; İstenirse birisi ebe olabilir	4

Yukarıda belirtilen bulunması zorunlu personelin yanı sıra psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve

diğer personele yardımcı olmak üzere bakım destek personeli çalıştırılabilir.

4.2.13. Sağlık Personeli Dışındaki İdari Personelle İlgili Değerlendirme

Özel hastanelerde yukarıda belirtilen hekim, diğer sağlık personeli ve hizmetliler dışında büro personeli, temizlik, güvenlik …v.b elemanlarında çalıştırılması gerekmektedir. Bu elemanlarca sağlanacak hizmetin bir bölümünün sözleşme ile başka işverenlerce sağlanması da mümkündür.

Bu konuda yapılacak incelemelerde;

- İşyerinde işin yürütümü ile ilgili iş ve işlemlerden hangilerinin sözleşme ile dışarıdan sağlandığı ve bu işleri yapan kişilerin sigortalılıklarının sağlanıp sağlanmadığı,

- Sözleşme ile satın alınan hizmetlerde sözleşmede belirtilmiş ise bu sayıda elemanın çalıştırılıp çalıştırılmadığı, sözleşmede sayı belirtilmemiş ise gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği,

- İşyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak işyerinde büro işlerinde kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği,

asgarî işçilik değerlendirmesi için tespit edilmelidir.

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel hastane/dal hastanesi işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Özel hastane/dal hastanesi işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59., 85., 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel hastane/dal hastanesinin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI (Özel Hastane Kuruluşları İçin)		
I-İŞYERİ VE İŞVEREN İLE İLGİLİ BİLGİLER		
1. İşverenin Adı Soyadı-Unvanı	:	
2. Sosyal Güvenlik Müdürlüğü	:	
3. İşyeri Sicil Numarası	:	
4. Ön İzin Belgesi Tarih Sayısı	:	
5. Ruhsat Tarih Sayısı	:	
6.Faaliyet İzin Belgesi Tarih Sayısı	:	
7.Yetkili Olunan Uzmanlık Dalları	:	

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER			
1.Hastane ruhsatı dışında birim ve üniteler için alınan ruhsat/açılma izni/uygunluk belgeleri	**Tarih**	**Sayı**	**Faaliyete Başlama Tarihi**
a-			
b-			
c-			
d-			

2-Temin Edilen Hizmetler	**Bünyeden**	**Dışardan**	**Firma ve Sözleşme Tarihi**
a)Laboratuar			
b)Röntgen			
c)Ambulans			
d) Diğer (Y.hane-Güvenlik-Temizlik ..vb.)			

3-İşyerinde Çalışan Personel Durumu (Sayısı)								
a) Yönetici Personel (Mesul Müdür,Müd. Yrd)	:							
b)Uzman Hekim (Uzmanlık Dalları)		Kadrolu		Part-Time		TOPLAM		
……..								
……..								
……..								
……..								
c) Hekim (Pratisyen)								
d) Sağlık Personeli								
Eczacı								
Hemşire								
Ebe								
Sağlık Memuru								
Anestezi Teknisyeni								
Laboratuar Teknisyeni								
Ameliyathane Hemşiresi								
Acil Tıp Teknisyeni								
Röntgen Teknisyeni								
Fizyoterapist								
Diyetisyen								
Sosyal Hizmet Uzmanı								
e)Diğer Personel (Büro Yemekhane,Temizlik, vb)								

4-Hasta/Yatak Bilgileri	Hasta		Yoğun Bakım		Gözlem		Toplam	
a)Hastane Yatak Sayısı								
b)Denetim Günü Yatan Hasta Sayısı								

5-Tıbbi Cihazlar:	

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(……..Sağlık İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …… adresinde kurulu ……. unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi, Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
2) Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
3) Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
4) Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
5) Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
6) Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)).

GÖNDERILECEK SURET

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(……..Sağlık İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …… adresinde kurulu ……. unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….…….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……..…… ……..…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

☐ **1)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi, Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde),
☐ **2)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
☐ **3)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
☐ **4)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
☐ **5)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
☐ **6)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),

KALACAK SÜRET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE
EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon : ……
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. (**X**) Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. (**X**) Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. (**X**) Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. (**X**) Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. (**X**) Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. (**X**) Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. (**X**) İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (**X**) Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. (**X**) Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. (**X**) Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. (**X**) Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. (**X**) Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. (**X**) Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. (**X**) Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri, (Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 17),
15. (**X**)Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri (Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge (2005-180)),
16. (**X**)……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "**……**" dır.

ÖNDERİLECEK SÜRET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE
EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. ☐ Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. ☐ Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. ☐ Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. ☐ Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. ☐ Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. ☐ Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri, (Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 17),
15. ☐Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri (Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge (2005-180)),
16. ☐ ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "**……**" dır.

KALACAK SÜRET

EK-5/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... ……..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... ……..... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... ……..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	**……..**
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. **(X)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. **(X)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. **(X)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. **(X)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. **(X)** Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri, (Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 17),
15. **(X)**Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri (Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge (2005-180)),
16. **(X)** ……..

GÖNDERILECEK SÜREÇ

EK-5/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	**……..**
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. ☐ Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. ☐ Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. ☐ Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. ☐ Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. ☐ Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. ☐ Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri, (Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 17),
15. ☐ Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri (Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge (2005-180)),
16. ☐ ……..

KALACAK SÜRET

EK-6

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Uzman Doktor, Pratisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Büro Elemanı, ..vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												

EK-7

BİLGİ ANAHTARI

		Protokol Kayıt Defteri	Adli Rapor Kayıt Defteri	Laboratuar Kayıt Defteri	Pansuman ve Enjeksiyon Kayıt Defteri	Denetim ve Teftiş Defteri	Cerrahi Müdahale Defteri	Ön izin, ruhsat, faaliyet izin belgesi esis izin belgesi, işletme izin belgesi, uygunluk belgesi,	Mesul müdür/sorumlu uzman belgeleri ve sözleşmeleri	Personel çalışma izin belgeleri, sözleşmeleri ve ilgili evrakları	Sağlık personeli dışında çalışan personelin isim listeleri	Denetim raporları ve ekleri	Müdürlüğe verilen Bilgi ve üç aylık Envanter Formları	Aylık Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Fişi	Hemşire Gözlem Kağıdı	Taburcu Muayene Bulguları Formu	Tıbbi Müdahale Raporu	Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri	Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri
1	İşyeri Unvanı						√	√	√			√	√	√					
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı						√	√	√										
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri							√	√										
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri							√	√										
5	İşyeri Adresi						√	√	√			√	√	√					
6	İşyeri Telefonu						√	√	√			√	√						
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması						√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√
8	Özel Hastane Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri									√	√	√							
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri									√	√	√							
12	Çalışanın İşe Başlama Tarihi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Çalışanın İşten Çıkış Tarihi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri								√	√	√								